

**QUESTION A CHOIX DOUBLE
(QCD)**

Questions à choix double

Consigne : Hachurez l'alvéole de la lettre A quand l'assertion est vraie et celle de la lettre B quand elle est juste.

- Q1. Seuls les déterminants de santé négatifs influencent l'état de santé d'une population.
- Q2. L'attitude à développer par le personnel de santé pendant l'étude du milieu est l'observation et le dialogue.
- Q3. La monographie est l'étude de la connaissance d'une région, d'un milieu culturel donné dans toutes ses dimensions physiques, sociales, économiques, culturelles et spirituelles.
- Q4. Un patrimoine génétique correct et complet est un facteur physiologique favorisant la maladie.
- Q5. Un système de santé est dit global lorsqu'il est accessible à tous dans les mêmes proportions sans discrimination.
- Q6. L'épidémiologie étudie à quelle fréquence les maladies touchent les populations humaines.
- Q7. Les effets du bruit sur la santé peuvent aboutir à des lésions organiques de l'appareil auditif.
- Q8. Tous les vaccins du PEV doivent être conservés entre 3C et 8C.
- Q9. Les associations vaccinales simultanées doivent être faites le même jour.
- Q10. Pour désinfecter l'eau trouble, il faut 3 gouttes d'eau de javel pour 10 litres d'eau.
- Q11. Une eau dure contient un déficit de magnésium, de calcium, de fluor, de calcaire, de l'iode.
- Q12. La sédimentation constitue un moyen de correction de la saveur et de l'odeur de l'eau.
- Q13. Une aération et une ventilation suffisante est un critère relatif aux besoins physiologiques.
- Q14. L'éradication d'une maladie vise à bloquer la propagation de la maladie dans la communauté.
- Q15. Le cabinet ou la latrine à fosse est un système d'évacuation des excreta avec entraînement à matières fécales.
- Q16. La référence est le fait que l'utilisateur de l'Etablissement Sanitaire de Premier Contact s'amène dans un autre établissement sanitaire de préférence par choix personnel.
- Q17. La référence est le fait que le prestataire de soins de l'Etablissement Sanitaire de Premier Contact amène le malade dans un établissement sanitaire de premier recours dit de référence parce que l'état de santé de ce dernier nécessite un plateau technique non disponible au niveau de l'ESPC.
- Q18. La Contre-référence définit comme le retour du patient dans l'établissement sanitaire de premier contact d'origine pour la poursuite de son traitement.

- Q19. La contre référence se définit comme le départ du patient de son village d'origine pour la poursuite de son traitement.
- Q20. Le but de la référence/contre référence est d'assurer la prise en charge la plus adéquate du malade, en vue de lui offrir des soins les plus adaptés et les plus qualifiés.
- Q21. Le but de la référence/contre référence est d'assurer la prise en charge la plus approximative du malade, en vue de lui offrir des soins acceptables.
- Q22. Pour décider de la référence, le prestataire de l'ESPC se sert de l'ordinogramme.
- Q23. Pour décider de la référence, le prestataire de l'ESPC se sert d'un chronogramme.
- Q24. Pour décider de la référence, le prestataire de l'ESPC informe et convainc le malade ou ses accompagnants de la nécessité de la référence.
- Q25. Pour décider de la référence, le prestataire de l'ESPC soumet à l'appréciation du malade ou à celle de ses accompagnants l'opportunité de la référence.
- Q26. Toute référence répond à une urgence.
- Q27. La fiche de référence est remise exclusivement au malade avec des explications d'accompagnement.
- Q28. La fiche de référence est remise exclusivement aux accompagnants avec des explications d'accompagnement.
- Q29. Une fois la fiche de référence et de contre-référence remise au malade ou aux accompagnants, le prestataire n'a plus besoin d'inscrire quoique ce soit dans le registre de consultation.
- Q30. En cas de référence urgente, le prestataire de l'ESPC n'est pas tenu d'avertir le service d'accueil, car celui-ci doit être prêt à tout moment pour ce genre de situations.
- Q31. La partie contre référence de la fiche peut retourner avec le malade dans l'ESPC d'envoi.
- Q32. Le prestataire de soins de l'ESPC se base sur les informations de la fiche de la contre référence pour continuer les soins nécessaires.
- Q33. Le CHR et même le CHU peut être considéré dans certaines circonstances comme un ESPC.
- Q34. Les malades référés sont pris en charge dès leur arrivée par un assistant social désigné par la hiérarchie du district sanitaire.
- Q35. A l'arrivée du malade dans la structure de référence l'agent de santé doit accueillir sans état d'âme le malade et le mettre dans de bonnes conditions psychologiques.
- Q36. Dans le cadre de la référence, si le malade doit être hospitalisé, le prestataire de soins doit entamer la démarche de soins pour une prise en charge globale du malade.
- Q37. Dans le cadre de la référence, si le malade doit être hospitalisé, le prestataire de soins doit garder le droit de réserve et ne parler qu'au malade seul.
- Q38. Dans le cadre de la référence, si le malade doit être référé à un autre niveau supérieur, le prestataire de soins se doit de les y accompagner à bord de l'ambulance requise.
- Q39. L'accessibilité géographique fait partie des facteurs à prendre en compte en cas de référence.
- Q40. L'environnement socio culturel du malade à référer fait partie des facteurs à prendre en compte en cas de référence.
- Q41. L'obédience politique du malade à référer fait partie des facteurs à prendre en compte en cas de référence.
- Q42. La capacité à négocier du malade à référer ou celle de ses accompagnants fait partie des facteurs à prendre en compte en cas de référence.
- Q43. Le comité de gestion (COGES) se définit comme « un groupe de personnes choisies par les membres de la communauté et qui contrôlent les agents de santé dans leurs activités »
- Q44. La création des comités de gestion (COGES) répond à la nécessité de confier la gestion du centre de santé aux populations, pour que celui-ci leur soit le plus utile possible.

- Q45. L'une des raisons pour lesquelles les centres de santé ne répondent pas toujours à l'attente des populations réside dans le fait que les populations elles-mêmes ne soient pas toujours associées aux activités du centre.
- Q46. Les règles de gestion des formations sanitaires rurales sont fixées par l'arrêté N° 93-218 du 03 février 1993.
- Q47. Comme but, la création du COGES répond à la nécessité d'associer la communauté comme membre actif aux activités de gestion du centre de santé.
- Q48. Le comité de gestion est composé de 12 à 20 personnes représentant les communautés villageoises bénéficiaires des prestations de la structure sanitaire.
- Q49. Le comité de gestion est composé uniquement de personnes issues de la communauté villageoise bénéficiaire des prestations de la structure sanitaire.
- Q50. L'infirmier, la sage-femme ou le travail social sont membres de droit de santé du COGES.
- Q51. Le chef du village, les Agents de Santé Communautaires (ASC) et les Accoucheuses Traditionnelles (AT) font d'office parti du COGES du fait de leurs rôles de prolongement des activités du centre dans les communautés.
- Q52. Il n'est pas recommandé que chaque village desservi par le centre de santé ait un représentant dans le COGES.
- Q53. La participation aux activités du COGES est intéressée par le versement d'émoluments mensuels aux membres.
- Q54. Les membres du comité de gestion sont désignés pour une durée de cinq (5) ans , renouvelable .
- Q55. Il n'y a pas de conditions préalables au choix des membres du COGES.
- Q56. Dans son rôle de gestion financière, le COGES décide du montant de la participation financière des communautés villageoises jusqu'à la hauteur qu'il juge utile.
- Q57. Dans son rôle de gestion des ressources humaines, le comité de gestion participe à la notation du personnel de santé.
- Q58. Dans son rôle de gestion des ressources humaines, le comité de gestion veille au savoir être du personnel de santé.
- Q59. Comme rôle dans la gestion du matériel, des médicaments et du local, le comité de gestion doit veiller à la disponibilité des médicaments essentiels et des vaccins.
- Q60. Comme rôle dans la gestion du matériel, des médicaments et du local, le comité de gestion doit veiller au suivi de la bonne gestion des stocks de matériel alloués au centre de santé pour son bon.
- Q61. Dans son rôle de gestion en dehors du centre de santé, le COGES doit faire connaître aux populations les activités promotionnelles, préventives, éducatives et curatives du centre.
- Q62. Dans son rôle de gestion en dehors du centre de santé, le COGES doit promouvoir la participation financière de l'Etat.
- Q63. Le plan d'action du centre de santé fait partie des outils de gestion des responsables de la gestion administrative et technique du comité de gestion.
- Q64. Le cahier des comptes rendus des différentes réunions du COGES fait partie des outils de gestion des responsables de la gestion administrative et technique du comité de gestion.
- Q65. Le budget de fonctionnement assuré par l'autofinancement fait partie des outils de gestion des responsables de la gestion financière du comité de gestion.
- Q66. Le président du COGES se charge d'ouvrir un compte au nom du centre de santé dans un établissement bancaire public ou privé.
- Q67. Le responsable de la gestion financière du COGES se charge d'ouvrir un compte au nom du centre de santé dans un établissement bancaire public ou privé.
- Q68. Le responsable de la gestion financière du COGES participe aux activités de supervision avec les autres membres du comité gestion.

- Q69. Le responsable de la gestion administrative et technique, outre sa fonction pour laquelle il est affecté au centre, est chargé d'encaisser quotidiennement les sommes représentant la participation financière de la population.
- Q70. Le responsable de la gestion administrative et technique du COGES, outre sa fonction pour laquelle il est affecté au centre, est chargé d'établir avec le comité de gestion, les priorités d'investissement et de fonctionnement en tenant compte des problèmes sanitaires de la localité et des activités planifiées.
- Q71. Les legs sont des sources de revenus du COGES.
- Q72. Les membres du COGES sont pris en compte par les primes d'intéressement de la structure de santé.
- Q73. Le paiement du salaire du personnel de la structure de santé est inscrit dans les dépenses du comité de gestion.
- Q74. Une partie de la participation des membres communautaires aux activités du COGES se voit dans la planification et la détermination des programmes.
- Q75. Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose a pour mission de contribuer à la réduction de la létalité de la tuberculose.
- Q76. Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose a pour mission de contribuer à un meilleur impact sur le système de santé.
- Q77. L'organisation et le fonctionnement du PNLT se font autour de deux versants qui sont: le versant administratif et le versant de prestidigitisation.
- Q78. Au niveau central, les services de Pneumo-phtisiologie sont des structures de soins du Programme National de Lutte contre la Tuberculose.
- Q79. L'un des buts de la stratégie DOTS est de mettre un terme à l'épidémie mondiale de tuberculose en réduisant le nombre de décès de 95% et l'incidence de 90% entre 2015 et 2035.
- Q80. L'un des buts de la stratégie DOTS est de faire en sorte que plus aucune famille ne fréquente les services chargés de traiter la tuberculose.
- Q81. L'un des buts de la stratégie DOTS est d'éviter le développement de virus multirésistants dû à des traitements anarchiques.
- Q82. L'un des cinq éléments de base de la stratégie DOTS est le système personnalisé d'enregistrement et de notification permettant d'évaluer constamment les résultats du dépistage et du traitement pour chaque patient.
- Q83. Le diagnostic de la tuberculose s'établit par des images radiographiques montrant des opacités et des cavités.
- Q84. Pendant l'étude du milieu, l'attitude à développer par le personnel de santé est la communication et le dialogue.
- Q85. La monographie est la connaissance des hommes et de l'environnement dans lequel ils vivent, des moyens et des problèmes qui existent dans ce milieu.
- Q86. la monographie est l'étude de la connaissance d'une région, d'un milieu culturel donné dans toutes ses dimensions physiques, sociales, économiques, culturelles et spirituelles.
- Q87. En monographie, les facteurs biologiques sont tous les aspects de la santé physique et mentale dont l'origine est à l'extérieur de l'organisme et dépendent de la structure de la biologie humaine.
- Q88. Au delà des soins classiques, le professionnel de santé exerçant dans un milieu social donné doit être un agent de développement.
- Q89. Les premières collectivités humaines se sont fondées le long des cours d'eau.
- Q90. De nos jours encore, l'eau demeure un facteur déterminant de déclin et de développement.

- Q91. La composante des SSP qui traite de l'approvisionnement en eau est formulée comme suite :« l'approvisionnement suffisant en eau cotable et des mesures d'assainissement de base ».
- Q92. Les eaux souterraines sont contenues dans le sous-sol et certaines qui émergent sous forme de sources. Elles sont couramment utilisées pour la consommation.
- Q93. Les eaux de surface sont aussi constituées par l'eau de pluie récoltée.
- Q94. Les pollutions domestiques sont les déchets de la vie humaine qui sont déversés dans les cours d'eau.
- Q95. Les pollutions industrielles sont les déchets des usines, les eaux de lavage, de refroidissement et de graissage.
- Q96. Les pollutions agricoles sont dues aux organismes génétiquement modifiés (OGM).
- Q97. Les pollutions diffuses ou collectives sont les pollutions provoquées par les détergents, les hydrocarbures et les huiles de vidanges.
- Q98. L'eau souterraine ne contient aucune impureté à cause du pouvoir filtrant du sol.
- Q99. Une eau est dure lorsqu'elle contient un excès de magnésium, de calcium, de fluor, de calcaire, et d'iode.
- Q100. L'eau potable est une eau qui ne contient aucun germe pathogène.
- Q101. Les puits constituent le moyen le plus courant de captage des eaux souterraines.
- Q102. L'eau trouble peut être corrigée par la décantation, la filtration, la sédentarisation.
- Q103. La saveur et l'odeur de l'eau peuvent être améliorées en utilisant du charbon activé.
- Q104. La correction des défauts bactériologiques de l'eau consiste à débarrasser l'eau des micro-organismes pathogènes qu'elle peut contenir.
- Q105. L'ébullition a pour inconvénient de faire perdre à l'eau les gaz dissouts.
- Q106. Pour cela il est nécessaire de l'aérer avant sa consommation.
- Q107. Le permanganate est un oxydant énergétique qui détruit les bactéries.
- Q108. Le bruit est un son indésirable, déplaisant ou agaçant, soit parce qu'il gêne la perception d'un autre son, soit parce qu'il est un hommage à la santé physique et psychique.
- Q109. La Communication se définit comme un processus statique par lequel un individu établit une relation avec une ou plusieurs personnes pour échanger, transmettre des idées, des connaissances.
- Q110. Le comportement est l'ensemble des manières de faire ou de pratiques propres à un individu ou à groupe d'individus.
- Q111. Le changement de comportement est la modification des manières de faire d'un individu ou d'un groupe d'individus.
- Q112. Le changement de comportement passe par un long cheminement qui s'effectue toujours rapidement compte tenu des facteurs susceptibles d'influencer l'adoption d'un nouveau comportement.
- Q113. Dans le processus de changement de comportement, les facteurs internes sont liés aux caractéristiques personnelles et psychologiques de l'individu.
- Q114. La décision d'un individu de modifier ou non son comportement est fonction d'un seul facteur.
- Q115. Les connaissances sont un préalable à tout changement de comportement individuel.
- Q116. Dans le changement de comportement, la perception est le processus par lequel un individu choisit, organise et interprète des éléments d'informations externes pour construire une image cohérente du monde qui l'entoure.
- Q117. Dans le changement de comportement, les croyances correspondent à un élément de connaissance descriptive qu'un individu entretient à l'égard d'un objet.
- Q118. Les attitudes résument les évolutions positives ou négatives, les réactions émotionnelles et les prédispositions à agir.

Q119. La culture est l'ensemble des normes, rites valeurs, convictions et habitudes d'une société.

Q120. La modification du comportement humain suit généralement un processus radical.

Q121. La segmentation consiste à découper un public cible donné en groupes hétérogènes afin de leur adresser des messages spécifiques et adaptés.

Q122. Dans le monitoring de l'activité de vaccination, la mauvaise estimation des besoins en vaccins est une cause probable du goulot d'étranglement situé entre la population cible et l'accessibilité géographique aux soins.

Q123. La méconnaissance des directives nationales pour la prise en charge des malades lors du monitoring des consultations des soins curatifs est une cause probable du goulot d'étranglement situé entre la couverture adéquate et la couverture effective.

Q124. La fiche de relevé ou de contrôle de la température du réfrigérateur dans le monitoring de l'activité de vaccination est un support de données qui sert à mesurer la couverture adéquate.

Q125. Les fiches de stock du FAF et de la SP sont des supports de données pertinents qui servent à mesurer la disponibilité des ressources dans le monitoring de l'activité de la CPNr

Q126. Approvisionner suffisamment l'ESPC en ressources nécessaires est une stratégie potentielle pour lever le goulot d'étranglement situé entre la population cible et la disponibilité des ressources.

Q127. Réduire l'intervalle de commande des vaccins à 1 mois est stratégie pour redresser le goulot d'étranglement situé entre la disponibilité des ressources et la population cible dans le monitoring de l'activité de vaccination

Q128. Rendre les cases de santé opérationnelles en formant les AT sur la CPNr est une stratégie pour lever le goulot d'étranglement situé entre l'accessibilité géographique et l'utilisation des services dans le monitoring de l'activité de la CPNr

Q129. La finalité du monitoring est d'apporter les solutions correctrices aux goulots d'étranglements

Q130. Le reste à budgétiser est une rubrique pour l'élaboration du budget des ressources propres d'un ESPC dans le cadre des SSP

Q131. La somme à budgétiser dans l'élaboration du budget des ressources propres d'un ESPC dans le cadre des SSP est aussi appelée recettes des six mois couverts par le monitoring

Q132. Le fonds de réserve dans l'élaboration du budget des ressources propres d'un ESPC dans le cadre des SSP se calcule en additionnant la somme à la banque après mouvement bancaire et les recettes de six mois couverts par le monitoring si celles-ci ne sont pas déposées sur le compte bancaire de l'ESPC.

Q133. Le montant alloué aux imprévus qui ne doit pas excéder 5% des dépenses obligatoires dans l'élaboration du budget des ressources propres d'un ESPC dans le cadre des SSP est une sous rubrique des dépenses de fonctionnement local.

Q134. Le rachat des médicaments essentiels est une sous rubrique des recettes issues de la vente des médicaments essentiels dans l'élaboration du budget des ressources propres d'un ESPC dans le cadre des SSP.

Q135. Les ressources propres dans la gestion financière d'un ESPC constituent 55% des recettes du livret de recettes et de dépenses.

Q136. Les autres dépenses de fonctionnement local en dehors du montant réservé aux imprévus dans l'élaboration du budget des ressources propres d'un ESPC dans le cadre des SSP constituent 95% de la somme à budgétiser.

Q137. Le salaire du personnel de soutien non rémunéré par l'Etat représente 20% des ressources propres dans le cadre de la gestion des recettes et dépenses de l'ESPC

Q138. Le taux d'incidence est le nombre de nouveaux cas de maladie enregistré pendant une année, rapporté au total de cas de maladies de la même période

Q139. Le taux brut de natalité est le nombre de naissances vivantes en une année, rapporté à la population totale de la même année multiplié par 100

Q140. Le dénominateur dans le calcul du taux de mortalité infantile est le nombre d'enfants âgé de 0 à 11 mois multiplié par 1000

Q141. Le taux de mortalité juvénile est le nombre d'enfants âgés de 1 à 4 ans rapporté au nombre total d'enfant de 1 à 4 ans

Q142. Le taux d'accouchement assisté est l'effectif des femmes enceintes ayant été assistées pendant l'accouchement par une personne qualifiée ou ayant au moins la qualification d'accoucheuse traditionnelle rapporté au total des grossesses attendues multiplié par 100

Q143. Un accouchement est dit assisté lorsqu'il est conduit par une personne qualifiée ou ayant au moins la qualification d'accoucheuse traditionnelle.

Q144. Les ONG sont des acteurs gênant pour apporter secours à la population sinistrée dans la gestion des catastrophes.

Q145. Les guides religieux sont des acteurs contournables de l'approche communautaire de gestion des catastrophes.

Q146. Les épidémies par la destruction des infrastructures sanitaires sont les conséquences sociales des catastrophes.

Q147. Les perturbations du mode de vie conduisant les populations les plus vulnérables à la prostitution, l'alcoolisme et la drogue sont les conséquences sanitaires des catastrophes

Q148. Les différends entre les membres d'une communauté ne constituent pas un obstacle à la participation communautaire

Q149. Dans le développement communautaire, la population doit participer à l'organisation de l'action communautaire ;

Q150. Adapter d'une manière continue les activités des agents de santé aux circonstances et aux situations nouvelles est un objectif de la supervision.

Q151. L'issu de la supervision est l'amélioration de l'incompétence et du rendement des agents de santé et de la qualité de service offert à la population.

Q152. Les méthodes directes et indirectes sont les deux méthodes utilisées lors de la supervision des agents de santé

Q153. L'observation et la correction sont les deux approches utilisées lors de la supervision des agents de santé

Q154. L'honnêteté, la disponibilité et l'inflexibilité doivent être les profils d'un bon superviseur

Q155. L'objectif de la santé pour tous avant l'an 2000 a été défini par l'assemblée mondiale de la Santé en 1977.

Q156. La conférence du 6 au 12 septembre 1978 au cours de laquelle la politique des SSP a été définie par l'OMS a eu lieu à ATA-ALMA en ex URSS

Q157. En 1985, les chefs d'état africains membres de l'OMS se sont retrouvés dans la capitale Zambienne (Lusaka) pour dégager trois niveaux d'application des SSP

- Q158. Les différents niveaux d'application des SSP sont le niveau stratégique et le niveau de mise en œuvre des activités.
- Q159. Le niveau de mise en œuvre des SSP est aussi appelé niveau primaire
- Q160. Le niveau de mise en œuvre des SSP est aussi appelé périphérique
- Q161. Le niveau d'appui des SSP est aussi appelé niveau secondaire
- Q162. Le niveau d'appui des SSP est aussi appelé niveau intermédiaire
- Q163. La gestion du niveau primaire est assurée par le Directeur départemental de la santé
- Q164. La gestion du niveau secondaire est assurée par le Directeur départemental de la santé
- Q165. Les infirmiers et les sages-femmes sont les prestataires des services du niveau périphérique
- Q166. Les infirmiers et les sages-femmes sont des prestataires de services du niveau intermédiaire
- Q167. Les médecins sont des prestataires de services du niveau primaires
- Q168. Les médecins sont les prestataires des services du niveau secondaire
- Q169. Les infirmiers et les sages-femmes sont des prestataires de services du niveau secondaire
- Q170. Les prestations de services des infirmiers et des sages-femmes se limitent au niveau primaire
- Q171. Le niveau central des SSP n'intervient pas dans les prestations de services de santé
- Q172. Le niveau central des SSP s'occupe seulement de la conception des politiques de santé
- Q173. La politique des SSP définie à l'initiative de Bamako a mis un accent particulier sur la lutte contre la mortalité maternelle et la mortalité infantile
- Q174. Le lancement officiel de la mise en œuvre des SSP en Côte d'Ivoire a eu lieu en 1993
- Q175. Le début effectif de la mise en œuvre des activités des SSP en Côte d'Ivoire a eu lieu en 1991 au district sanitaire de Bouaflé
- Q176. Les SSP sont des soins essentiels car ils répondent aux besoins fondamentaux des populations
- Q177. Les SSP sont adaptés car leur mise en œuvre tient contre des caractéristiques socioculturelles et des besoins de santé des populations
- Q178. Les SSP sont intégrés car ils constituent une entité indépendante du système national de santé
- Q179. Les SSP sont intégrés car ils constituent une entité dépendante du système national de santé
- Q180. Le but particulier des SSP en Côte d'Ivoire est l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant
- Q181. La mise en œuvre de la politique des SSP en Côte d'Ivoire est axée en partie sur la participation communautaire
- Q182. En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend huit composantes essentielles
- Q183. En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend deux composantes curatives
- Q184. En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend deux composantes préventives et trois composantes curatives
- Q185. En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend deux composantes préventives et trois composantes promotionnelles
- Q186. En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend trois composantes préventives et deux composantes promotionnelles
- Q187. En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend trois composantes préventives et trois composantes promotionnelles
- Q188. En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend trois composantes préventives et trois composantes promotionnelles
- Q189. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend deux versants
- Q190. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend de haut en bas, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central
- Q191. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend de bas en haut, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central
- Q192. La pyramide sanitaire ivoirienne comporte des structures de gestion qui sont le district sanitaire, le District régional et le Ministère de la santé et de l'Hygiène publique
- Q193. La pyramide sanitaire ivoirienne comporte un versant de prestation de services composé des CSU, du CHR et des instituts spécialisés
- Q194. Le PEV ivoirien a été mis en place en 1978.

- Q195. Le vaccin est une substance qui a le désavantage d'avoir un effet moins durable que le sérum
- Q196. Le sérum est une substance qui a le désavantage d'avoir un effet moins durable que le Vaccin
- Q197. Tout vaccin est administré pour assurer une protection spécifique.
- Q198. Le vaccin utilise les défenses de l'organisme pour assurer sa protection contre les maladies
- Q199. Le BCG est un vaccin bactérien inactivé
- Q200. La dose de BCG à administrer à une cible du PEV est de 0,05cc
- Q201. La voie d'injection du BCG est la face externe du haut du bras ou épaule gauche
- Q202. Le DTC-HepB+Hib est une association simultanée d'antigènes
- Q203. La première dose de DTC-HepB+Hib s'administre à l'âge d'un mois et demi.
- Q204. Le DTC-HepB+Hib s'administre chez l'enfant à mi-hauteur de la face externe de la cuisse
- Q205. Le point d'injection du DTC-HepB+Hib est l'intramusculaire
- Q206. Le VPO est un vaccin vivant qui s'administre en trois doses chez l'enfant entre 0 et 11 mois
- Q207. Le VPO et le VPI protègent contre la même maladie
- Q208. On peut administrer le VPI à tous les enfants âgés entre 0 et 11 mois sans exception
- Q209. On peut administrer le VPO à tous les enfants âgés entre 0 et 11 mois sans exception
- Q210. Le VPI est un vaccin inactivé qui s'administre par voie orale
- Q211. Le VPI est un vaccin inactivé qui s'administre en sous-cutanée
- Q212. Le VPI ne doit pas être utilisé en cas de congélation de son flacon.
- Q213. Le VPI est un vaccin qui s'administre en quatre doses, chez l'enfant entre 0 et 11 mois.
- Q214. La population cible du PEV ivoirien est composée des enfants de 0 à 11 mois et des femmes en âge de reproduction
- Q215. Le VAA est un vaccin vivant qui nécessite un rappel tous les dix ans
- Q216. Le RotaTeq est un vaccin vivant non atténué qui s'administre par voie orale à raison de 2ml par dose
- Q217. Le VAT s'administre chez la femme enceinte dans le seul but le prévenir le tétanos chez celle-ci
- Q218. Le VAT est une anatoxine qui peut être congelée sans inconvénient
- Q219. Il est possible d'oublier l'administration d'un antigène contenu dans une association combinée de vaccins
- Q220. En matière de vaccination, l'intervalle minimum n'existe pas
- Q221. Pour un enfant ayant abandonné la vaccination pendant une longue période, il est recommandé de reprendre son calendrier dans sa totalité
- Q222. Une injection est dite sécurisée lorsqu'elle s'administre dans le strict respect des règles d'asepsie
- Q223. MAPI signifie Manifestation Post Immunisation
- Q224. Les MAPI sont toujours liés à une erreur de conservation des vaccins
- Q225. On parle de rupture de la chaîne du froid si et seulement si la température du réfrigérateur est supérieure à 8°C
- Q226. On parle de rupture de la chaîne du froid si et seulement si la température du réfrigérateur est inférieure à 2°C
- Q227. Il n'y a pas de rupture de la chaîne du froid lorsque la température du réfrigérateur est comprise entre -2°C et +8°C
- Q228. En cas d'altération des vaccins par la chaleur ou la congélation, il faut les jeter immédiatement et faire une nouvelle commande au district sanitaire

- Q229. Le test d'agitation des anatoxines concerne tous les vaccins du PEV, chaque fois qu'il ya suspicion de congélation
- Q230. Le relevé de la température du réfrigérateur des vaccins se fait de façon quotidienne
- Q231. Il est recommandé de conserver les vaccins du programme élargi de vaccination entre -2°C et 8°C.
- Q232. A l'exception du BCG et du VPO, la dose à administrer pour les autres vaccins du PEV est de 0,5 ml.
- Q233. Les différents vaccins associés de façon combinée ont toujours le même point d'injection.
- Q234. Entre deux doses d'un vaccin à contacts multiples, on peut observer un intervalle de plus de 4 semaines.
- Q235. Chez un enfant mal vacciné, le vaccin prioritaire à lui administrer le jour du rattrapage est toujours le VAR.
- Q236. Un enfant correctement vacciné est celui qui reçoit toutes les doses de vaccins inscrites dans le programme élargi de vaccination.
- Q237. Les emballages isothermes et les chambres froides produisent du froid.
- Q238. Le système de santé de la Côte d'Ivoire offre trois types de soins qui sont les soins précaires, les soins secondaires et les soins tertiaires.
- Q239. Les ressources humaines pour la santé regroupent entre autres les travailleurs non médicaux qui assurent la gestion et le soutien dans les services de santé.
- Q240. Les objectifs d'un système de santé consistent à restaurer la santé, promouvoir la maladie et assurer la prévention de la santé.
- Q241. La globalité d'un système de santé se mesure par sa capacité à offrir des soins préventifs et des soins curatifs à la population.
- Q242. Un système de santé peut être efficace sans être efficace.
- Q243. Les soins sont dits accessibles lorsqu'ils sont mis à la disposition de toutes les populations quelque soit leur localisation géographique
- Q244. La stratégie avancée est le seul moyen de rendre le système de santé physiquement accessible aux populations vivant loin d'une structure de santé
- Q245. L'une des insuffisances du système de santé ivoirien est son manque d'équité
- Q246. Un système de santé qui a la capacité d'apprécier une situation qui prévaut et de mesurer le niveau d'atteinte de ses objectifs est dit planifiable
- Q247. Un système qui permet à l'agent de santé de s'adresser à la structure de son choix et au malade de son choix admet la liberté
- Q248. L'histoire du système de santé a connu successivement la période d'après l'indépendance la période d'avant l'indépendance
- Q249. L'objectif principal du système post colonial était de maintenir en bonne santé la main d'œuvre destinée au développement économique
- Q250. Le système de santé pré-indépendance n'était pas global accordait une priorité à la main d'œuvre valide au détriment des autres couches sociales
- Q251. Pendant la période coloniale les ressources humaines pour la santé étaient en nombre réduit et formées sur le tas et à l'école de médecine Jules CARDE en France.
- Q252. Le système de santé colonial était caractérisé par une infrastructure maximale de base avec 23 lits en 1902.
- Q253. De 1960 à 1980, l'objectif principal du système post-colonial était la consolidation des acquis en matière d'infrastructures, de personnel et de financement.
- Q254. La population cible vaccinale est la proportion de la population totale qui bénéficie de l'activité vaccinale.

Q255. En Côte d'Ivoire les populations cibles du PEV sont identiques selon qu'on soit en vaccination de routine ou en campagne de vaccination.

Q256. En Côte d'Ivoire les populations cibles des campagnes de VPO, de VAT et de VAR sont respectivement les enfants de 0 à 59 mois, les femmes enceintes et les enfants de 9 mois à 14 ans

Q257. En Côte d'Ivoire, l'objectif vaccinal est identique en vaccination de campagne pour tous les vaccins.

Q258. Les doses perdues ne doivent pas être prises en compte dans l'estimation des besoins en vaccins.

Q259. Le taux de perte représente la proportion de vaccins sortie du stock et qui n'a pas été administrée à la cible.

Q260. Le taux de pertes de vaccin est un indicateur de la qualité des services de vaccination.

Q261. Le taux d'utilisation représente la proportion de vaccin sortie du stock et qui a été effectivement administrée pendant la séance de vaccination.

Q262. Plus le taux de perte est élevé, plus le facteur de perte est élevé

Q263. Plus le taux de perte est élevé, moins le facteur de perte est bas

Q264. Plus le facteur de perte est élevé, moins le facteur de perte est élevé

Q265. Moins le taux de perte est élevé, plus le facteur de perte n'est bas

Q266. Moins le taux de perte est élevé, plus le facteur de perte n'est élevé

Q267. Moins le facteur de perte est élevé, moins le facteur de perte est bas

Q268. Plus le taux de perte est élevé, plus le facteur de perte est bas

Q269. Les facteurs inévitables de pertes de vaccins peuvent être améliorés par une bonne gestion des vaccins.

Q270. Les doses sacrifiées sont les doses de vaccins qu'on aura inconsciemment perdues pour que la vaccination ait lieu.

Q271. Le besoin théorique des vaccins représente 25% du stock de sécurité

Q272. La quantité à commander n'est pas toujours égale au besoin réel

Q273. La PCV permet de vérifier la péremption du vaccin

Q274. Le taux de couverture vaccinal global est la proportion de la population cible ayant reçu le nombre requis de doses de chaque antigène du PEV

Q275. Plus la population cible ayant reçu le nombre requis de doses de vaccins de chaque antigène est élevé, plus le taux de couverture vaccinal global est élevé

Q276. Une donnée représente l'imput ou le produit fini

Q277. Une donnée est considérée comme un produit informatif

Q278. L'information sanitaire est toute information qui se rapporte aux différentes composantes du système de santé

Q279. Un système d'information sanitaire est l'ensemble des éléments qui interagissent pour aboutir à la production de l'information sanitaire

Q280. La collecte des données sanitaires est aussi appelée enregistrement des données

Q281. Le taux de mortalité infantile est une donnée sanitaire

Q282. Le nombre de consultations prénatales constitue une donnée sanitaire

Q283. La transmission des rapports d'activités sanitaires se fait du versant prestataire au versant gestionnaire de la pyramide sanitaire ivoirienne

Q284. Les délais de transmission des rapports A et A3 sont respectivement le 5 du mois suivant et le 30 janvier de l'année en cours

Q285. Le rapport mensuel C1 du CHR est transmis chaque mois au district sanitaire avant le 15 du mois suivant.

Q286. Le rapport annuel C2 du CHR est transmis chaque mois à la direction régionale de la santé avant le 30 janvier de l'année suivante

Q287. Le rapport annuel A3 du CSU est mensuellement transmis au district sanitaire avant le 30 janvier de l'année suivante

Q288. Le rapport mensuel D1 de la direction départementale de la santé est transmis à la direction régionale de la santé avant le 10 du premier mois du trimestre suivant

Q289. Les premiers rapports D1 de l'année 2018 ont été transmis par les directions départementales de la santé à leurs directions régionales sanitaires respectives au plus tard le 10 Avril 2108

Q290. Les premiers rapports E1 de l'année 2018 ont été transmis par les directions départementales de la santé à leurs directions régionales sanitaires respectives au plus tard le 10 Mars 2018

Q291. La complétude dans la transmission des rapports est le fait de transmettre la totalité des rapports d'activités sanitaires au service destinataire dans le temps requis.

Q292. Un bon taux de complétude traduit forcément un bon taux de promptitude

Q293. Le taux de complétude peut être important même si les services ne transmettent pas les rapports dans les délais requis.

Q294. Le traitement des données ne peut se faire qu'avec les outils informatiques

Q295. Le traitement des données consiste à se servir des données pour prendre des décisions de gestion.

Q296. L'interprétation des données sanitaires consiste à donner une explication aux tendances que présentent les données collectées

Q297. La diffusion de l'information est la communication des informations aux personnes chargées de prendre des décisions.

Q298. Chaque mois, les prestataires de soins des CSU remplissent deux exemplaires des rapports mensuels d'activités qu'ils déposent au district sanitaire dont ils dépendent.

Q299. Le système de gestion de l'information sanitaire ivoirien se nomme SIGE

Q300. La stratégie fixe consiste pour l'agent de santé de vaccination au sein de sa structure sanitaire, les populations cibles du PEV vivant dans un rayon de 0 à 5 kilomètre.

Q301. Les données des différentes séances de vaccination effectuées pendant les stratégies mobiles sont prises en compte dans le calcul des différents taux de couverture de lu centre de santé le plus proche des localités où la vaccination a été faite

Q302. Le projet se déroule sur une période relativement courte que celle du programme

Q303. Le programme porte en général sur des objectifs d'une envergure nationale

Q304. Le suivi et l'évaluation permettent de mesurer objectivement l'impact attribuable à l'intervention du programme/projet.

Q305. L'évaluation initiale aussi appelée analyse situationnelle

Q306. Un indicateur est une variable qui mesure un aspect d'un projet/programme.

Q307. Un indicateur n'est pas toujours une variable quantitative.

Q308. Les indicateurs permettent de mesurer la performance des acteurs d'un projet/programme

**QUESTION A CHOIX MULTIPLES
(QCM)**

I. Questions à Choix Multiple (QCM)

Consigne : Hachurer sur la grille de réponse, avec le bic noir, les alvéoles des lettres correspondant aux bonnes réponses.

Q1. Cocher les trois (3) différents niveaux de perception des besoins de santé de la population qui figurent dans la liste suivante :

- A. Le niveau des besoins latents
- B. Le niveau des besoins profonds
- C. Le niveau des besoins ressentis
- D. Le niveau des besoins inexprimés
- E. Le niveau des besoins exprimés
- F. Le niveau des besoins immédiats

Q2. La liste ci-dessous contient quatre (4) vaccins du programme élargi de vaccination (PEV) et les doses à injecter.

- 1. Le BCG
- 2. Le DTC-HepB+Hib
- 3. Le vaccin RotaTeq

Doses à injecter

- a. 2 ml
- b. 0,05 ml
- c. 2 gouttes
- d. 0,5 ml

Déterminer les doses à injecter pour chaque vaccin en choisissant les trois bonnes réponses (lettres en majuscule)

- A. (1, b)
- B. (1, d)
- C. (2, b)
- D. (2, d)
- E. (3, a)
- F. (3, c)

Q3. La chaîne de froid doit être toujours conservée car :

- A. les vaccins sont thermosensibles
- B. l'altération des vaccins est réversible
- C. les effets de l'altération des vaccins d'additionnent.

Q4. Parmi ces éléments cités, relève la cause des MAPI (Manifestation Adverse Post Immunisation).

- A. Erreur sur les étiquettes des flacons (PCV, date de péremption, numéro du lot).
- B. Erreur au niveau de la conservation ou de la préparation du vaccin.
- C. Erreur au niveau de la manipulation ou de l'administration du vaccin

- D. Erreur au niveau de la conservation, la préparation, la manipulation ou de l'administration du vaccin.

Q5. Relève dans la liste ci-dessous, les quatre pollutions auxquelles l'eau est exposée :

- A. Les pollutions collectives.
- B. Les pollutions atmosphériques.
- C. Les pollutions industrielles.
- D. Les pollutions métallurgiques.
- E. Les pollutions agricoles.
- F. Les pollutions domestiques.

Q6. Cette liste contient les différentes maladies liées à l'eau ainsi que des exemples de maladies. Faites correspondre à chaque type de maladies son exemple. (cocher les trois bonnes réponses).

- 1. Les maladies virales.
- 2. Les maladies parasitaires.
- 3. Les maladies bactériennes.

Exemples de maladies

- a. Le choléra
- b. Les schistosomiasés
- c. La poliomyélite
- d. La fièvre jaune

- A. (1, c)
- B. (1, d)
- C. (2, a)
- D. (2, b)
- E. (3, a)
- F. (3, b)

Q7. Parmi ces éléments, relève les trois (3) critères de choix d'une source d'approvisionnement en eau potable.

- A. La profondeur de la source.
- B. La salubrité de la source.
- C. La grandeur de la source.
- D. La régularité de la source.
- E. L'aspect économique de la source.
- F. L'accessibilité de la source.

Q8. Cocher les trois (3) méthodes de désinfection chimique de l'eau à domicile contenues dans cette liste.

- A. L'ionisation.
- B. L'ébullition.
- C. La javellisation.
- D. La filtration.
- E. Le permanganate.
- F. La décantation.

Q9. Parmi les raisons suivantes, quatre (4) sont responsables du problème de l'habitat dans les pays en développement. Lesquelles ?

- A. L'alphabétisation.
- B. La forte poussée démographique.
- C. Le chômage.
- D. L'exode rural.
- E. L'urbanisation rapide.
- F. La pauvreté.

Q10. Parmi les critères suivants, relève les quatre (4) qui permettent de mesurer la salubrité de l'habitat.

- A. Critères relatifs aux besoins biologiques
- B. Critères relatifs aux besoins psychologiques
- C. Critères relatifs aux besoins psychiatriques
- D. Critères relatifs aux besoins physiologiques
- E. Critères relatifs aux besoins de sécurité
- F. Critères relatifs à la protection contre la contagion

Q11. L'une de ces affirmations ci-dessous est correcte. Laquelle ?

- A. L'évacuation des ordures ménagères se fait en deux phases.
- B. L'évacuation des ordures ménagères se fait en trois phases.
- C. L'évacuation des ordures ménagères se fait en quatre phases.
- D. L'évacuation des ordures ménagères se fait en cinq phases.

Q12. Parmi les éléments suivants, relève le moyen de lutte contre le péril fécal.

- A. Porter des habits longs
- B. Fermer les portes et fenêtres
- C. Porter des chaussures fermées
- D. Se laver régulièrement

Q13. Cocher les deux modes de transmission des maladies par les vecteurs.

- A. La transmission géologique
- B. La transmission mécanique
- C. La transmission manuelle
- D. La transmission biologique
- E. La transmission orale
- F. La transmission transcutanée

Q14. Relier les deux méthodes de lutte contre les moustiques aux éléments ci-dessous : (cocher la bonne combinaison en lettre majuscule).

1. La lutte contre les larves de moustique
2. La lutte contre les moustiques adultes

Les éléments :

- a. Drainer et combler les flaques d'eau et autres endroits où l'eau peut stagner.
- b. Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide.
- c. Réparer les fosses septiques et les caniveaux d'élimination des eaux usées.
- d. Pulvériser l'intérieur des maisons d'insecticides.

- e. Porter des vêtements longs et clairs à la tombée de la nuit.
- f. Eliminer ou réduire les gîtes de reproduction par le désherbage des pourtours des concessions.

- A. (1, a, b, c) et (2, d, e, f)
- B. (2, a, b, c) et (1, d, e, f)
- C. (1, a, b, d) et (2, c, e, f)
- D. (1, a, c, f) et (2, b, d, e)

Q15. Parmi les éléments suivants, relève celle qui correspond à la bonne affirmation.

- A. L'émetteur, le récepteur, le message et le canal sont les éléments constitutifs de la communication.
- B. L'émetteur, le récepteur, le message, le canal et la rétroaction sont les éléments constitutifs de la communication.
- C. L'émetteur, le récepteur, le message, le canal et le code sont les éléments constitutifs de la communication.
- D. L'émetteur, le récepteur, le message, le canal, le code et la rétroaction sont les éléments constitutifs de la communication.

Q16. Cocher les quatre (04) principales caractéristiques des SSP.

- A. Soins essentiels
- B. Soins valables
- C. Soins accessibles
- D. Soins acceptables
- E. Soins adaptés
- F. Soins intégrés

Q17. Le seul principe fondamental des SSP contenu dans cette liste est :

- A. Les soins doivent faire partie intégrante du système de protection sanitaire national.
- B. Les activités doivent être pleinement intégrées à celles des autres secteurs de développement communautaires (agriculture, éducation, etc.)
- C. L'accès universel aux soins et la couverture en fonction des besoins
- D. Les soins doivent avant tout reposer sur les ressources locales.

Q18. Parmi les propositions ci-dessous, indiquez les deux qui font partir des aspects techniques du DOTS :

- A. Identification des patients phthisiques ; ☐
- B. Chimiothérapie personnalisée de courte durée ; ☐
- C. Enregistrement et notification des progrès et de la guérison. ☐

Q19. Parmi les propositions ci-dessous, indiquez les deux qui font partir des aspects techniques du DOTS :

- A. Dépistage des cas et diagnostic ; ☐
- B. Trithérapie standardisée de courte durée ; ☐
- C. Observation directe pendant la deuxième phase du traitement (DOT) ;

Q20. Parmi les propositions ci-dessous, indiquez celle qui fait partir des aspects logistiques du DOTS :

- A. Approvisionnement fiable en aliments et produits de première nécessité pour les phthisiques ☐
- B. Laboratoires pour l'examen radiographique ; ☐
- C. Supervision et formation des personnels de santé.

Q21. Parmi les propositions ci-dessous, indiquez celle qui fait partir des aspects logistiques du DOTS :

- A. Approvisionnement fiable en médicaments et produits de diagnostic ; ☐
- B. Laboratoires pour les examens de tout genre ; ☐
- C. Supervision et monitoring des personnels de santé.

Q22. Parmi les propositions ci-dessous, indiquez celle qui fait partir des aspects politiques du DOTS :

- A. Engagement des fonds publics ; ☐
- B. Formulation des politiques ; ☐
- C. Mobilisation des hommes politiques ;

Q23. Parmi les propositions ci-dessous, indiquez celle qui fait partir des aspects politiques du DOTS :

- A. Engagement des pouvoirs publics ; ☐
- B. Orientation des politiques ; ☐
- C. Autonomisation des ressources ;

Q24. La stratégie DOTS est d'une importance capitale dans les stratégies de lutte contre la tuberculose. Indiquez l'action qu'elle permet de faire parmi les propositions suivantes :

- A. S'assurer de la prise effective des médicaments ;
- B. Garantir les chances de récupération ;
- C. Éviter la sélection des virus résistants ;

Q25. La stratégie DOTS est d'une importance capitale dans les stratégies de lutte contre la tuberculose. Indiquez l'action qu'elle permet de faire parmi les propositions suivantes :

- A. S'assurer de la prise définitive des médicaments ;
- B. Définir les chances de guérison ;
- C. Raccourcir la période de contagiosité ;

Q26. La stratégie DOTS est d'une importance capitale dans les stratégies de lutte contre la tuberculose. Indiquez l'action qu'elle permet de faire parmi les propositions suivantes :

- A. Réduire la morbidité, la mortalité et les cas secondaires ;
- B. Parcourir la période de contagiosité ;
- C. Assurer un service de qualité au patient et à la communauté.

Q27. Retenez parmi les propositions suivantes deux des objectifs de lutte antituberculeuse au niveau central et intermédiaire :

- A. Dépister au moins 70% des TPMP-;
- B. Guérir au moins 85% des TPM+ nouvellement dépistée ;
- C. Installer des structures de prise en charge dans les différentes directions sanitaires
- D. Augmenter la couverture du TDO à 100% sur l'ensemble du territoire national ;
- E. Impliquer la communauté dans les activités de dépistage de la tuberculose.

Q28. Retenez parmi les propositions suivantes deux des objectifs de lutte antituberculeuse au niveau d'un établissement sanitaire de premier contact

- A. Rendre 100% des malades dépistés non contagieux au départ du traitement
- B. Augmenter le taux de dépistage à 80% des malades attendus ;
- C. Améliorer le taux de guérison à 85% des malades dépistés ;
- D. Réduire le taux de perdu de vue à 5%

Q29. Identifiez parmi les propositions suivantes deux rôles de l'infirmier et de la sage-femme dans la lutte contre la tuberculose :

- A. Assurer une bonne organisation de la prise en charge ;
- B. Identifier un superviseur de son traitement parmi le personnel de santé ;
- C. Établir un climat de confiance entre le malade et sa famille ;
- D. Dénoncer les malades qui ne viennent pas au traitement

Q30. Identifiez parmi les propositions suivantes deux rôles de l'infirmier et de la sage-femme dans la lutte contre la tuberculose :

- A. Indiquer au malade le seul lieu de traitement possible pour lui ;
- B. Expliquer le plan du traitement ;
- C. Vérifier les données de la carte de traitement ;
- D. Ignorer les effets secondaires du traitement ;

Q31. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui correspond à un outil de gestion

- A. La carte rouge : elle reste avec le malade qui la ramène à chaque visite au centre ;
- B. La carte rose : elle reste au centre et permet de vérifier la régularité de la prise des médicaments ;
- C. La carte verte : elle reste chez l'assistant social en cas de perte de la carte du traitement du patient de retrouver son numéro.

Q32. Identifiez parmi les propositions ci-dessous, deux gestes posés par le prestataire de l'ESPC lors de la décision pour la référence :

- A. Se sert du chronogramme de la structure sanitaire
- B. Suggère au malade ou à ses accompagnants la nécessité de la référence ;
- C. Remplit la fiche de référence tout en mentionnant le caractère urgent ou non de la référence ;
- D. Remet exclusivement au malade la fiche de référence avec des explications d'accompagnement ;

Q33. Identifiez parmi les propositions ci-dessous, deux gestes posés par le prestataire de l'ESPC lors de la décision pour la référence :

- A. Remplit la fiche de référence avec la mention du caractère urgent ou non;
- B. Remet au malade ou aux accompagnants la fiche de référence avec des émoluments d'accompagnement ;
- C. Inscrit dans le registre de consultation du Système d'Information et de Gestion (SIG), la date et l'heure de la référence ;
- D. En cas de référence urgente, avertir le service d'accueil par tous moyens.

Q34. Indiquez parmi les propositions ci-dessous, l'un des gestes posés par le prestataire de soins de l'ESPC lors de la contre référence :

- A. Range la fiche de référence dans les archives du service pour l'avoir en mémoire
- B. Se base sur les informations données par les accompagnants pour continuer les soins nécessaires ;
- C. Il remplit le dossier de synthèse du malade à l'aide des informations de la fiche de la contre référence.

Q35. Précisez parmi les gestes ci-dessous celui posé par le prestataire de soins au niveau de l'Hôpital Général de référence à l'arrivée du malade

- A. Accueillir humainement le malade et le mettre dans de bonnes conditions physiologiques ;
- B. Rassurer le malade ou ses accompagnants sur la bonne prise en charge et sur la possibilité de guérison ;
- C. Se fier aux constantes d'accompagnement et l'orienter vers le médecin chargé de consultation des malades référés.

Q36. Précisez parmi les gestes ci-dessous celui posé par le prestataire de soins au niveau de l'Hôpital Général de référence si le malade doit être hospitalisé.

- A. Informer, dans le cadre du secret médical, uniquement le malade sur la maladie et la nécessité de son hospitalisation ;
- B. dissiper la crainte ou la peur singulière de ses accompagnants en les rassurant sur l'issue de la maladie ;

- C. mettre le malade dans un lit en attendant que les accompagnants remplissent les formalités administratives pour son hospitalisation ;

Q37. Précisez parmi les gestes ci-dessous celui posé par le prestataire de soins au niveau de l'Hôpital Général de référencesi le malade doit être hospitalisé.

- A. Veiller à ce que les bulletins des examens complémentaires demandés soient bien rédigés ;
- B. Expliquer au malade ou à ses accompagnants, les différents prestations offerts au niveau de l'hôpital ;
- C. Entamer la démarche de soins pour une prise en charge globale du malade.

Q38. Identifiez parmi les propositions ci-dessous présentées, deux Facteurs à prendre en compte en cas de référence.

- A. Temps à mettre pour atteindre le centre de référence qui dépendra de son accessibilité géographique ;
- B. Le nombre des accompagnants qui peut varier suivant le cas en présence
- C. Les antécédents d'une éventuelle référence antérieure
- D. La capacité financière du malade ou de ses accompagnants ;

Q39. Le comité de gestion d'un ESPC est Composé de :

- A. 10 à 20 personnes représentant les communautés bénéficiaires des prestations.
- B. 12 à 20 personnes représentant les communautés bénéficiaires des prestations.
- C. 10 à 15 personnes représentant les communautés bénéficiaires des prestations.

Q40. Les membres du comité de gestion sont désignés pour une durée de :

- A. Trois (3) ans, renouvelable.
- B. Quatre (4) ans, renouvelable.
- C. Cinq (5) ans, renouvelable.

Q41. Indiquez deux critères dont il faut remplir les conditions pour être membre du COGES :

- A. Savoir lire et écrire dans une autonomie totale
- B. Résider en permanence dans un village desservi par le centre de santé ;
- C. Ne pas avoir commis de délit public ou d'ordre culturel ;
- D. Avoir une expérience de gestion de revenus.

Q42. Indiquez l'un des rôles du COGES dans la gestion financière parmi les propositions ci-dessous :

- A. décide d'annuler les montants de la participation financière des communautés villageoises
- B. décide des dépenses de fonctionnement supportées par la participation financière de l'Etat
- C. élabore le budget semestriel;

Q43. Indiquez l'un des rôles du COGES dans la gestion financière parmi les propositions ci-dessous :

- A. suit le mouvement de l'argent à la banque ;
- B. Établit les tranches de répartitions des coûts des actes de santé
- C. Paye le personnel de santé de la structure

Q44. Dans son rôle dans la gestion des ressources humaines, le comité de gestion doit veiller :

- A. À la présence du personnel de santé ;
- B. À la qualité de la fréquentation entre les consultants et le personnel ;
- C. Au savoir-faire du personnel de santé.

Q45. Identifiez deux rôles du COGES dans la gestion du matériel, des médicaments et du local, le comité de gestion doit veiller :

- A. à l'indisponibilité des médicaments essentiels et des vaccins ;
- B. à la propreté du centre de santé ;
- C. à l'éclairage des logements de fonction du centre de santé et à leur approvisionnement en eau potable ;
- D. à la promiscuité des locaux et du matériel ;
- E. à l'entretien des locaux et du matériel.

Q46. En dehors du centre de santé le comité de gestion doit :

- A. faire connaître aux populations les activités promotionnelles, préventives, éducatives et curatives du centre ;
- B. promouvoir la participation financière de l'Etat ;
- C. promouvoir l'acceptabilité des services offerts par la population ;

Q47. En dehors du centre de santé le comité de gestion doit :

- A. promouvoir la participation financière de la population ;
- B. encourager les changements d'attitudes ou de comportements observés au niveau des différents acteurs et utilisateurs
- C. promouvoir l'évaluation participative de la population

Q48. Parmi les outils de gestion ci-dessous présentés, indiquez trois utilisés par le Responsable de la gestion administrative et technique :

- A. les registres du système d'informations et de gestions
- B. le cahier de versement journalier du centre ;
- C. les reçus des sommes confiées au président du COGES;
- D. le plan des bâtiments du centre de santé ;
- E. le cahier des comptes rendus des différentes réunions du COGES.
- F. l'inventaire de tous les produits utilisés au centre

Q49. Parmi les outils de gestion ci-dessous présentés, indiquez trois utilisés par le Responsable de la gestion financière.

- A. un livret d'ouverture de compte d'épargne;
- B. le livret de caisse pour noter chaque fois les entrées et les sorties de fonds ;
- C. les carnets mères-enfants vendus ;
- D. les justificatifs des fonds déposés dans le compte ;
- E. les justificatifs des dépenses effectuées ;
- F. le budget de fonctionnement assuré par l'état.

Q50. Parmi les activités proposées indiquez deux qui relèvent du président du COGES.

- A. ouvrir un coffre au nom du centre de santé dans un établissement bancaire privé ;
- B. convoquer les réunions en accord avec le responsable de la gestion financière qui dirige les débats pour parvenir à un consensus ;
- C. faire tous les retraits de l'argent à la banque ;
- D. coordonner les activités du COGES ;
- E. d'organiser les supervisions et les contrôles périodiques de la gestion financière avec l'équipe cadre du district.

Q51. Parmi les activités proposées indiquez deux qui relèvent du responsable de la gestion financière du COGES.

- A. recueillir à la fin de chaque journée de travail, les sommes d'argent collectées par le personnel de santé ;
- B. enregistrer les dépenses du centre de santé dans le livret de caisse ;
- C. faire à la fin de chaque journée le cumul des sommes versées à la banque ainsi que celui des dépenses effectuées ;
- D. établir le bilan de la gestion financière du centre de santé, donner une copie au président et déposer une autre copie au district ;
- E. diriger les activités de supervision avec les autres membres du comité gestion ;

Q52. Parmi les activités proposées, indiquez outre sa fonction, deux qui relèvent du Responsable de la gestion administrative et technique du COGES.

- A. Assurer les tâches du secrétariat du COGES ;
- B. Convoquer les réunions du comité de gestion en accord avec le trésorier et rédige les procès verbaux ;
- C. Établir avec le comité de gestion, les priorités d'investissement et de fonctionnement en tenant compte des problèmes sanitaires de la localité et des activités planifiées ;
- D. Élaborer le budget du centre de santé à partir des ressources propres.

Q53. Parmi les propositions indiquez deux sources de revenus du COGES.

- A. La subvention de l'Etat

- B. Les dons et gels.
- C. Les actes de santé;
- D. La vente de certains documents,
- E. Les dons et legs.

Q54. Au nombre des propositions faites, indiquez deux qui relèvent du domaine de dépense du COGES :

- A. Salaire de l'ensemble du personnel du centre de santé ;
- B. Entretien courant des locaux, du matériel et du mobilier ;
- C. Fournitures techniques et administratives ;
- D. Consommation en denrées alimentaires pour le personnel de garde.

Q55. Retenez deux aspects techniques de la stratégie DOTS :

- A. Dépistage des cas et diagnostic ; ☐
- B. Chimio prophylaxie standardisée de courte durée ; ☐
- C. Observation directe pendant la phase secondaire du traitement ; ☐
- D. Enregistrement et notification des progrès et de la guérison

Q56. Retenez deux aspects logistiques de la stratégie DOTS :

- A. Approvisionnement fiable en médicaments et produits de diagnostic ; ☐
- B. Laboratoires pour l'examen radioscopique ; ☐
- C. Supervision et formation des personnels de santé.
- D. Recensement de tous les cas suspects

Q57. Retenez deux aspects politiques de la stratégie DOTS :

- A. Engagement des pouvoirs publics ; ☐
- B. Formulation des politiques ; ☐
- C. Motivation des ressources humaines ;
- D. Création de structures communautaires de dépistage

Q58. Au nombre des propositions, identifiez trois éléments sur lesquels repose l'importance de la stratégie DOTS :

- A. S'assurer de la prise effective des médicaments ;
- B. Garantir les chances de traitement ;
- C. Eviter la sélection des bacilles résistants ;
- D. Réduire la morbidité, la mortalité et les cas extrapulmonaires ;
- E. Raccourcir la période d'analyse ;

F. Rendre un meilleur service au patient et à la communauté.

Q59. Identifiez parmi les propositions faites un objectif de la lutte antituberculeuse au niveau d'un établissement sanitaire de premier contact :

- A. Augmenter le taux de dépistage à 80% des malades attendus ;
- B. Améliorer le taux de traitement à 85% des malades dépistés ;
- C. Réduire le taux de perdu de vue à 5%

Q60. Retenez trois rôles de l'infirmier ou de la sage-femme pour une bonne observance du traitement antituberculeux :

- A. Communiquer avec le malade et sa famille, dans un langage simple, accessible, adapté au milieu culturel et au niveau d'instruction ;
- B. S'assurer du niveau de contagiosité du malade, des résultats de l'analyse, et la mise en œuvre du traitement et du T.D.O. ;
- C. Indiquer au malade le lieu de traitement et répondre à ses questions et préoccupation ;
- D. Expliquer le plan du traitement ;
- E. Reprise des mêmes messages par l'ensemble du personnel ;
- F. Redéfinir une bonne organisation de la prise en charge ;

Q61. Retenez trois rôles de l'infirmier ou de la sage-femme pour une bonne observance du traitement antituberculeux :

- A. Vérifier les données de la carte de traitement ;
- B. Identifier un contrôleur dans la famille ;
- C. Établir un climat de confiance entre le malade et sa famille ;
- D. Encourager pour les problèmes pouvant perturber l'observance du traitement
- E. Référer immédiatement le malade face en cas problème médical
- F. Rechercher les irréguliers et analyser les causes d'abandon de traitement.

Q62. Retenez au nombre de ces facteurs influençant la santé, les deux bonnes formulations.

- A. Facteurs défavorisant la santé ;
- B. Facteurs favorisant la maladie ;
- C. Facteurs déterminant la santé ;
- D. Facteurs défavorisant la maladie ;
- E. Facteurs déterminant la maladie ;

Q63. Identifiez dans les formulations ci-dessous deux facteurs physiologiques en faveur de la santé :

- A. un patrimoine génétique correct et complet ;
- B. une absence de troubles cataboliques ;
- C. une absence de troubles métaboliques ;
- D. un apport normal des éléments psychologiques

Q64. Identifiez dans les formulations ci-dessous trois facteurs psychologiques en faveur de la santé :

- A. une absence de troubles physiques ;
- B. une affection parentérale durant l'enfance ;
- C. la satisfaction du besoin d'être aimé, du besoin d'estime de soi, du besoin d'être reconnu ;
- D. un sevrage bien réduit ;
- E. une éducation adéquate de l'enfant ;
- F. la satisfaction du besoin de s'occuper, de se rendre utile (travail, emploi,...).

Q65. Identifiez dans les formulations ci-dessous trois facteurs de l'environnement physique ou socio-économique et culturels psychologiques en faveur de la santé :

- A. l'existence d'un habit salubre ;
- B. l'existence d'eau courante ;
- C. la présence de promiscuité, de pollution ;
- D. un milieu salubre;
- E. un SMIG raisonnable ;
- F. l'existence de moyens de sonorisation acceptables

Q66. Identifiez au nombre des propositions faites trois rôles du document monographique:

- A. avoir à coup d'œil sur « le tableau de bord » du centre de santé toutes les informations utiles et nécessaires concernant l'aire sanitaire ou le bassin de desserte ;
- B. connaître les problèmes sanitaires de la localité permettant ainsi de dégager les thèmes éducationnels en vue de sensibiliser la population ;
- C. permettre à l'agent de santé, d'être en désharmonie avec la population pour laquelle il travaille;
- D. diffuser des données cartographiques et méthodologiques fiables et récentes sur la structure sanitaire;
- E. recenser les différentes composantes d'une communauté donnée afin de l'aider à mieux s'organiser.

Q67. L'élaboration d'un document monographique d'un milieu social donné fait appel à plusieurs éléments ; indiquez-en trois dans la liste ci-dessous:

- A. la genèse de l'aire sanitaire ou du bassin de desserte ;
- B. les données relatives aux ressources humaines ;
- C. les données topographiques et géologiques ;
- D. les données relatives à l'hygrographie ;
- E. les livres relatifs à l'éducation ;
- F. les données relatives à l'agriculture et à l'alimentation ;

Q68. Indiquez le rôle de la cartographie dans la monographie parmi les propositions ci-dessous

- A. étendre l'aire sanitaire ou bassin de desserte;
- B. disposer de formations sur les voies de communication et les infrastructures socioéconomiques , culturelles et spirituelles de la localité ;
- C. localiser facilement les différents problèmes sanitaires de la localité.

Q69. Indiquez deux données relatives à l'identification de la structure sanitaire :

- A. le nom de la localité où est implantée la structure sanitaire ;

- B. la domination de la structure sanitaire ;
- C. la date de couverture des locaux du centre de santé ;
- D. de la localisation géographique de la structure sanitaire par rapport au district et à la région sanitaire.

Q70. Retenez dans la liste ci-dessous deux différentes sources de pollutions de l'eau :

- A. Les pollutions atmosphériques
- B. Les pollutions industrielles
- C. Les pollutions agricoles,
- D. Les pollutions virtuelles

Q71. Reliez les différentes maladies liées à l'eau et la teneur en éléments chimiques.

Teneur en éléments chimiques

- 1. Excès en éléments chimiques
- 2. Insuffisance en éléments chimiques

Maladies

- a) le goitre endémique
- b) la fluorose
- c) la carie dentaire
- d) le saturnisme

- A. (1. b, d)
- B. (2. a, c)
- C. (1. b, d)
- D. (2. a, c)
- E. (1. b, c)
- F. (2. b, c)

Q72. Sur la liste ci-dessous, retenez les trois qualités physiques d'une eau potable.

- A. liquide ;
- B. fraîche ;
- C. incolore ;
- D. indolore ;
- E. aérée

Q73. Reliez les différentes maladies liées à l'eau au type de germe pathogène.

Germes mis en cause

- 1. Bactéries
- 2. Parasites
- 3. Virus

Maladies

- a) dysenterie amibienne
- b) fièvre typhoïde
- c) schistosomiase
- d) poliomyélite
- e) choléra

- A. (1. b, d)
- B. (2. a, c)
- C. (3. d, e)
- D. (1. b, e)
- E. (2. a, b)

Q74. Identifiez deux critères de choix d'une source d'approvisionnement en eau potable :

- A. la particularité de la source
- B. salubrité de la source,
- C. la régularité de la source
- D. la captivité de la source

Q75. Indiquez dans la liste ci-dessous, quatre différents types de puits que nous pouvons rencontrer dans l'approvisionnement en eau potable.

- A. les puits suspendus
- B. les puits forgés
- C. les puits foncés
- D. les puits forés
- E. les puits cartésiens
- F. les puits artésiens

Q76. Pour protéger l'eau d'un puits traditionnel, identifiez dans la liste trois précautions nécessaires :

- A. le puits doit être placé loin de toute source de contamination
- B. en cas de terrain plat, le puits doit être situé au moins à 5 mètres de toute source de contamination
- C. en cas de terrain en pente, le puits doit être placé en aval des sources de contamination
- D. le puits doit être nettoyé et régulièrement désinfecté;
- E. le puits doit avoir une margelle de 0,70 centimètres
- F. le puits doit être entouré d'une aire cimentée d'un rayon de 2 à 3 mètres.

Q77. Indiquez dans la liste, trois critères relatifs aux besoins physiologiques

- A. une absence d'humidité ;
- B. une aération et une ventilation suffisante ;
- C. un appareillage adéquat ;
- D. une protection suffisante contre les rayons du soleil ;
- E. un espace suffisant pour les jeux des enfants ;
- F. une surface par individu de 2 à 3 m² pour éviter la promiscuité.

Q78. Indiquez dans la liste, deux critères relatifs aux besoins psychologiques

- A. La préservation de l'intimité ;
- B. L'existence de confort ;
- C. La possibilité d'assurer le déplacement personnel ;
- D. La cosmétique des habitants.

Q79. Indiquez dans la liste, trois critères relatifs à la protection contre la contagion

- A. L'approvisionnement en eau potable et en eau courante ;
- B. L'évacuation des déchets solides et liquides (eaux usées) ;
- C. La lutte contre les nuisances sonores ;
- D. La protection des animaux contre toute souillure.

Q80. Cochez les deux objectifs de l'hygiène du milieu dans la liste suivante :

- A. Prévenir la morbidité prématurée ;
- B. Prévenir les maladies et les traumatismes ;
- C. Assurer le bon rendement des organes sensibles ;
- D. Assurer le confort.

Q81. Trois phases interviennent dans le processus d'évacuation des ordures ménagères.

Ce sont :

- A. le stockage ;
- B. le paquetage ;

- C. le curage ;
- D. le ramassage ;
- E. le traitement.
- F. le déversement

Q82. Sur la liste des propositions, indiquez trois moyens de lutte contre le péril fécal

- A. porter des chaussures fermées ;
- B. assurer la stabilité de l'eau ;
- C. se rincer les mains avant de manger ;
- D. se laver les mains avant les selles ;
- E. protéger les aliments contre les arthropodes, notamment les mouches
- F. cuire les aliments ou désinfecter ceux consommés crus;

Q83. Sur la liste des propositions, indiquez trois critères de bon système d'évacuation des excréta

- A. le sol superficiel ne doit pas être contaminé par les excréta ;
- B. l'eau de surface ne doit pas être contaminée par les excréta ;
- C. les eaux souterraines ne doivent pas être prémunies ;
- D. les excréta ne doivent pas être manipulés
- E. les excréta ne doivent pas être éliminés dans les latrines.
- F. l'installation adoptée doit être très simple et onéreuse

Q84. Retenez dans la liste, les trois conditions d'installation d'un cabinet ou latrine à fosse :

- A. Eviter de placer la latrine en aval d'un puits ou d'une source ;
- B. Prévoir entre la latrine et les puits, une distance d'au moins 5 mètres ;
- C. Le fond de la latrine doit être situé au moins à 1,5 mètres en-dessous de la nappe aquifère à condition que le sol soit homogène ;
- D. La construction d'une latrine dans des zones contenant des roches fissurées ou des formations calcaires doit être précédée d'une enquête minutieuse ;
- E. L'emplacement de la latrine doit être dans un endroit sec et bien drainé
- F. L'emplacement de la latrine doit être situé au-dessus du niveau de crue.

Q85. Indiquez sur la liste proposée deux moyens de lutte contre les larves de moustique :

- A. Dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticide
- B. Collecter tous les récipients pouvant contenir de l'eau ;
- C. Drainer et combler les flaques d'eau et autres endroits où l'eau peut stagner ;
- D. Réparer les fosses septiques et les caniveaux d'élimination des eaux usées;
- E. Reprendre les gîtes de reproduction par le désherbage des pourtours des concessions.

Q86. Indiquez sur la liste proposée deux moyens de lutte contre les moustiques adultes :

- A. dormir sous un drap imprégnée d'insecticide ;
- B. poser des grillages aux portes et fenêtres de tous les locaux d'habitations ;
- C. pulvériser l'intérieur des maisons d'insecticides ;
- D. porter des vêtements longs et sombres à la tombée de la nuit ;
- E. utiliser des crèmes antipaludiques.

Q87. Retenez dans la proposition, deux effets du bruit sur la santé :

- A. L'irritation ;
- B. Les irrigations des organes ;
- C. Les modifications du caractère ;

D. La diminution de la tension artérielle

Q88. Reliez les obstacles à la communication et leurs sources.

Sources	obstacles
1. Emetteur	a) Non maîtrise du sujet
2. Récepteur	b) Refus de message
3. Message	c) Non-respect des autres
	d) Compliqué
	e) Mauvaise attitude
	f) Absence de feed-back
	g) Inapproprié
	h) Méfiance
A. (1. a, c)	
B. (1. e, h)	
C. (2. b, d)	
D. (2. f, h)	
E. (3. b, g)	
F. (3. d, g)	

Le livret de caisse d'un centre de santé rural mentionne 2.650.555f comme recettes brutes après six mois d'activités. A partir de ce qui précède,

Q89. Le Fonds d'Aide Social se chiffre à

A-265.055,5 f

B-256.055,5 f

C-206.555,5 f

D-260.555,5 f

Q90. L'intéressement du personnel est de

A-379.385,25 f

B-357.983,25 f

C-397.583,25 f

D-387.937,25 f

Q91. Le salaire du personnel de soutien non payé par l'Etat est de

A-503111 f

B-530111 f

C-501311 f

D-531011 f

Q92. les dépenses totales se chiffrent à

A-1.947.219,75f

B-1.924.179,57f

C-1.921.479,57f

D-1.912.749,75f

Q93. les ressources propres sont égales à

1.547.085,25f

1.457.805,25f

1.574.508,25f

1.754.058,25f

Q94. Cochez les phrases qui constituent des composantes de SSP :

A-Education appropriée pour la santé en relation avec les problèmes de maladie auxquels la population est confrontée

B-Protection maternelle et infantile y compris la santé de la reproduction et la planification familiale.

C-Promotion et la lutte contre les endémies locales.

D-Prévention de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.

E-Vaccination contre les principales maladies endémiques.

Q309. Identifier parmi ces vaccins, ceux qui sont vivant atténués :

A.Le VAR

B.VAA

C.BCG

D.VPO

Q310. Identifier parmi les vaccins suivants, ceux qui sont inactivés :

A.VPI

B.DTC-HEPB-hiB

C.VPO

D.VAR

Q311. Identifier parmi les maladies suivantes, celles qui sont ciblées par le PEV ivoirien :

A.La tuberculose

B.Le tétanos néonatal ;

C.La coqueluche ;

D.L'hépatite A

E.Les otites à pneumocoque

F.Les pneumonies à pneumocoque

Q312.L'administration du vaccin RotaTeq est contre-indiquée chez l'enfant:

- A. en cas de vomissements
- B. en cas de diarrhée
- C. fièvre de 38°C

Q313. Identifier les informations qui sont exactes pour le vaccin PCV13 :

- A. il est administré en trois doses
- B. il est administré en sous-cutané
- C. il n'a aucune contre-indication
- D. il est conservé entre 2 et 8°C

Q314. Identifier les informations qui sont justes pour le VAR :

- A. Il est inactivé
- B. il s'administre toujours à l'enfant à partir de 9 mois
- C. il provoque des réactions indésirables
- D. il s'administre en sous-cutané

Q315. Parmi les contre-indications vaccinales, indiquez celles qui sont erronées :

- A. altération d'état général de l'enfant
- B. état de malnutrition de l'enfant
- C. maladie grave nécessitant une hospitalisation
- D. prématurité de l'enfant

Q316. Un enfant âgé de 2 semaines ayant reçu sa dose de BCG et sa première dose de VPO :

- A. est correctement vacciné
- B. est complètement vacciné
- C. n'est ni correctement ni complètement vacciné

Q317. Un enfant de 4 mois qui n'a pas encore reçu sa 3e dose de DTC-HepB-Hip :

- A. est correctement vacciné
- B. est complètement vacciné
- C. n'est ni correctement ni complètement vacciné

Q318. Pour un enfant de 6 mois reçu ce jour dans votre centre de vaccination et ayant déjà reçu sa 3e dose de DTC-HepB-Hip vous lui administrerez:

- A. Une dose de VAR
- B. Une dose de VAR et une dose de VAA
- C. Aucune dose de vaccin

Q319. Un nourrisson présentant une infection à VIH avérée ou présumée et/ou des signes et des symptômes de SIDA doit recevoir:

- A. une dose de VAR à 3 mois
- B.une dose de VAR à 6 mois
- C.une dose à 9 mois
- D.aucune dose de VAR

Q320. Identifiez parmi les vaccins suivants, ceux qui sont éligibles au test d'agitation des anatoxines :

- A.DTC-HepB-Hip
- B.VAT
- C.VPO
- D.Ratateq

Q321. Pour un enfant âgé de 8 mois qui n'a jamais été vacciné, il faut lui administrer en priorité :

- A.Le BCG
- B.Le DTC-HepB-Hib
- C.Le VPO

Q322. Les principales infections couramment transmises par les injections à risque sont :

- A.l'hépatite A
- B.l'hépatite C
- C.le tétanos

Q323. Le maintien de la chaîne du froid est important dans le cadre des activités de vaccination pour trois raisons fondamentales :

- A.Les vaccins sont thermosensibles
- B.L'altération des vaccins est réversible
- C.Les effets successifs des altérations s'additionnent

Q324. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui produisent du froid :

- A.les chambres froides ;
- B.les réfrigérateurs.
- C.Les emballages isothermes

Q325. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui conservent le froid :

- A.Les emballages isothermes ;
- B.Les coussinets en mousse ;
- C.Les congélateurs

Q326. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui permettent de monitorer la chaîne du froid au centre de santé :

- A. Les PVC
- B. Le thermomètre
- C. Le thermostat

Q327. Les vaccins suivants sont bactériens

- A. BCG
- B. VPO
- C. VPI
- D. RotaTeq
- E. VAR
- F. VAA
- G. VAT

Q328. Les vaccins ci-dessous sont injectables

- A. DTC-HepB-Hib
- B. VPO
- C. RotaTeq
- D. PCV-13

Q329. Les vaccins suivants peuvent être congelés

- A. BCG
- B. DTC-HepB-Hib
- C. VPO
- D. VPI
- E. VAT

Q330. Les activités suivantes sont du domaine de la prévention :

- A. la vaccination
- B. le dépistage volontaire du VIH /SIDA
- C. les spots publicitaires télévisés relatifs aux problèmes de santé
- D. la consultation prénatale
- E. la sensibilisation en vue de l'utilisation des moustiquaires imprégnées

Q331. Identifiez les éléments qui composent un système de santé :

- A. les structures de santé
- B. le personnel soignant
- C. la politique de santé
- D. les ressources financières

E.les populations

F.l'accessibilité aux soins

G.les maladies infectieuses

Q332. Identifiez parmi ces phases, celles qui concernent les objectifs d'un système de santé:

A. Restaurer la santé

B. Assurer la prévention de la santé

C. Assurer la promotion de la maladie

Q333. Les différents types de soins offerts par le système de santé sont :

A. les soins primaires

B. les soins secondaires

C. les soins curatifs

D. les soins tertiaires.

E. les soins préventifs

Q334. Parmi les éléments suivants, sélectionnez ceux qui influencent l'offre de soin :

A. l'implication du secteur privé en matière de santé

B. l'importance de l'activité des tradithérapeutes

C. la pyramide sanitaire

Q335. Le système de santé ivoirien est financé par :

A. L'état ivoirien

B. Des entreprises privées

C. Les populations

D. Des ONG étrangères

E. Des pays étrangers

F. Des assurances

G. Des banques

Q336. Pendant la période coloniale, l'organisation de l'hygiène collective a concerné entre autres :

A. l'hygiène en milieu scolaire ;

B. l'hygiène au niveau des marchés ;

C. l'hygiène dans les prisons ;

D. l'approvisionnement en eau saine.

E. l'hygiène dans les lieux de culte

Q337. Les actions de prophylaxie en période coloniale ont porté sur :

A. le dépistage des cas de maladies ;

B. la vaccination,

C. isolement des cas dépistés.

D. le traitement des cas dépistés ;

E. les stratégies fixes

F. les stratégies avancées

Q338. De 1994 à 1997, les problèmes prioritaires du système de santé Ivoirien concernent :

- A.le Programme Elargi de Vaccination
- B.la mise en place d'un système général d'assurance maladie
- C.la promotion des ressources humaines
- D.le renforcement du système de recouvrement des coûts des actes de santé
- E.l'amélioration et le développement de structures de formation
- F.l'établissement des bases d'une politique axée sur la participation communautaire des soins de santé

Q339.Pour une population totale de 3000 habitants, la population cible de la campagne de VPO est de :

- A.1350 enfants
- B.600 enfants
- C.120 enfants

Q340.Pour une population totale de 3000 habitants, la population cible de la campagne de VAT est de :

- A.1350 femmes
- B.600 femmes
- C.150 femmes

Q341.Pour une population totale de 3000 habitants, la population cible de la campagne de VAR est de :

- A.1350 femmes
- B.600 enfants
- C.120 femmes

Q342.Parmi les vaccins suivants, sélectionnez ceux qui sont administrés en Côte d'Ivoire à raison de plus d'un contact :

- A.DTC-HepB+Hib
- B.RotaTeq
- C. VPI
- D.PCV13
- E.VPO

Q343.Selon les normes de l'OMS, pour ouvrir un flacon de 20 doses de BCG il faut réunir un minimum de :

- A.12 enfants de 0 à 11 mois
- B.15 enfants de 0 à 11 moins

C.18 enfants de 0 à 11 mois

Q344.Selon les normes de l'OMS, avec un flacon de 20 doses de BCG il faut vacciner au minimum :

A.12 enfants de 0 à 11 mois

B.15 enfants de 0 à 11 mois

C.18 enfants de 0 à 11 mois

Q345.Selon les normes de l'OMS, avec un flacon de 20 doses de VPO il faut vacciner au minimum :

A.15 enfants de 0 à 11 mois

B.18 enfants de 0 à 11 mois

C.16 enfants de 0 à 11 mois

Q346.Selon les normes de l'OMS, pour ouvrir un flacon de 20 doses de VPO il réunir au moins :

A.15 enfants de 0 à 11 mois

B.18 enfants de 0 à 11 mois

C.16 enfants de 0 à 11 mois

D.01 enfant de 0 à 11 mois

Q347.Selon les normes de l'OMS, avec un flacon de 20 doses de VAR il faut vacciner au minimum :

A.12 enfants de 0 à 11 mois

B.15 enfants de 0 à 11 mois

C.16 enfants de 0 à 11 mois

Q348.Selon les normes de l'OMS, pour ouvrir un flacon de 20 doses de VAR il réunir au moins :

A.12 enfants de 0 à 11 mois

B.15 enfants de 0 à 11 mois

C.16 enfants de 0 à 11 mois

Q349.Selon les normes de l'OMS, avec un flacon de 20 doses de VAT il faut vacciner au minimum :

A.16 enfants de 0 à 11 mois

B.18 enfants de 0 à 11 mois

C.15 enfants de 0 à 11 mois

Q350.Selon les normes de l'OMS, pour ouvrir un flacon de 20 doses de VAT il réunir au moins :

A.16 enfants de 0 à 11 mois

B.18 enfants de 0 à 11 mois

C.15 enfants de 0 à 11 mois

Q351.Selon les normes de l'OMS, avec un flacon de 20 doses de VAA il faut vacciner au minimum :

A.15 enfants de 0 à 11 mois

B.17 enfants de 0 à 11 mois

C.14 enfants de 0 à 11 mois

Q352.Selon les normes de l'OMS, pour ouvrir un flacon de 20 doses de VAA il réunir au moins :

A.15 enfants de 0 à 11 mois

B.17 enfants de 0 à 11 mois

C.14 enfants de 0 à 11 mois

Q353.Les facteurs de pertes évitables de vaccins comprennent :

A.la mauvaise gestion des stocks de seringues ;

B.la défaillance de la chaîne de froid ;

C.la non maîtrise des techniques vaccinales par le personnel de santé

D.le respect de la politique du flacon entamé ;

E.les casses ou vol des vaccins.

Q354.Les facteurs inévitables de perte des vaccins comprennent :

A. les vaccins reconstitués qui doivent être jetés à la fin de la séance.

B.la mauvaise utilisation de vaccins reconstitués dans des conditions inadaptées au respect de PFE

C.la défaillance de la chaîne de froid ;

Q355.Les doses gaspillées sont des vaccins qui sont perdus, pour les raisons suivantes:

A.la date de péremption passée

B.les casses,

C.les vols

D.la détérioration due à la congélation

E.les flacons à PCV virée

Q356.Les doses sacrifiées concernent :

A.les doses jetées après reconstitution des vaccins

B.les doses administrées à des populations hors cibles

C.les doses des flacons cassés

Q357.Les vaccins du PEV qui sont sensibles à la lumière sont :

A.BCG

B.VAR

C.VAA

Q358.Identifier parmi ces vaccins, ceux qui sont sensibles à la congélation:

A.DTC-HepB-Hipb ;

B.VAA

C.VAT

D.VAR

Q359.Identifier parmi ces vaccins, ceux qui sont éligibles au test d'agitation des anatoxines :

A.DTC-HepB+Hib

B.VAT ou PCV13

C.BCG

D.VPI

Q360.Un flacon de vaccin liquide déjà ouvert est réutilisable à condition :

A.qu'il ne soit pas périmé

B.ait été contaminé

C.n'ait pas été exposé excessivement au froid ou à la chaleur excessive ;

D.ait été immergés dans de l'eau ;

E.ne présente aucun trouble ou précipitation ;

F.n'ait pas de PCV virée.

Q361.Un flacon de vaccin liquide déjà ouvert n'est plus utilisable :

A.lorsqu'il n'est pas périmé

B.lorsqu'il a été contaminé

- C.lorsqu'il été exposé excessivement au froid ou à la chaleur excessive ;
- D.lorsqu'il n'a pas été immergé dans de l'eau ;
- E.lorsqu'il présente un trouble ou précipitation ;
- F. lorsqu'il n'a pas de PCV viré.

Q362. Identifiez les vaccins du PEV auxquels s'applique la politique du flacon entamé s'applique

- A.VPO
- B.DTC-HepB-Hip
- C.VAT
- D.VAA

Q363. Identifiez les vaccins du PEV inéligibles à la politique du flacon entamé :

- A.VPO
- B.VAT
- C. BCG
- D.VAR
- E.VAA

Q364. Identifiez les vaccins qui peuvent être conservés pendant plus de 6 heures après l'ouverture du flacon :

- A.VPO
- B.VAT
- C.BCG
- D.VAR
- E.VAA

Q365. Parmi ces éléments, identifiez ceux qui constituent des causes d'abandon vaccinal

- A.le mauvais accueil des mères par le personnel
- B.les MAPI dues à la non maîtrise des techniques vaccinales par le personnel
- C.les ruptures fréquentes de vaccins
- D. les occasions manquées de vaccination

Q366. Parmi ces éléments, identifiez ceux qui constituent des causes d'abandon vaccinal

- A.absence de recherche active des cibles non vaccinées

B.planification des séances de vaccination non adaptée aux activités socioculturelles et économiques des populations

C.la longue attente des mères due à une mauvaise organisation des séances de vaccination

Q367.Parmi les éléments suivants, identifiez ceux qui peuvent être des solutions pour réduire les abandons vaccinaux :

A.réduire les MAPI par la formation du personnel vaccinateur

B.rechercher activement les populations cibles vaccinées

C.réduire les ruptures fréquentes de vaccins par une gestion rigoureuse des stocks et des commandes adaptées à l'effectif des populations cibles.

D.planifier les séances de vaccination sans tenir compte des activités socioculturelles et économiques des populations.

Q368.Le taux d'abandon général de la vaccination varie:

A.uniquement en fonction du nombre de doses de BCG administrées à la population cible

B.en fonction du nombre de doses de VAR administrées à la population cible

C.en fonction du nombre de doses de VAR et de BCG administrées à la population cible

D.en fonction du nombre de doses de VAA et de BCG administrées à la population cible

Q369.Le taux d'abandon général de la vaccination varie:

A.uniquement en fonction du nombre de doses de VAR administrées à la population cible

B.en fonction du nombre de doses de VAA administrées à la population cible

C.en fonction du nombre de doses de VAA et de BCG administrées à la population cible

D.en fonction du nombre de doses de VAR et de BCG administrées à la population cible

Q370.Le taux d'abandon du DTC-HepB+Hib de la vaccination varie:

A.uniquement en fonction du nombre de premières doses administrées à la population cible

B.en fonction du nombre de deuxièmes doses administrées à la population cible

C.en fonction du nombre de doses de premières doses et de deuxièmes doses administrées à la population cible

D.en fonction du nombre de doses de premières doses et de troisièmes doses administrées à la population cible

Q371.Le taux d'abandon du DTC-HepB+Hib de la vaccination varie:

A.uniquement en fonction du nombre de deuxièmes doses administrées à la population cible

B.en fonction du nombre de deuxièmes doses administrées à la population cible

C.en fonction du nombre de doses de premières doses et de deuxièmes doses administrées à la population cible

D.en fonction du nombre de doses de deuxièmes doses et de troisièmes doses administrées à la population cible

Q372.Le taux d'abandon du VPO de la vaccination varie:

A.uniquement en fonction du nombre de deuxièmes doses administrées à la population cible

B.en fonction du nombre de deuxièmes doses administrées à la population cible

C.en fonction du nombre de doses de premières doses et de deuxièmes doses administrées à la population cible

D.en fonction du nombre de doses de deuxièmes doses et de quatrièmes doses administrées à la population cible

Q373.Le taux d'abandon du VPO de la vaccination varie:

A.uniquement en fonction du nombre de premières doses administrées à la population cible

B.en fonction du nombre de troisièmes doses administrées à la population cible

C.en fonction du nombre de doses de premières doses et de quatrièmes doses administrées à la population cible

D.en fonction du nombre de doses de deuxièmes doses et de quatrièmes doses administrées à la population cible

Q374.Le taux d'abandon du VAT de la vaccination varie:

A.uniquement en fonction du nombre de premières doses administrées à la population cible

B.en fonction du nombre de troisièmes doses administrées à la population cible

C.en fonction du nombre de doses de premières doses et de cinquièmes doses administrées à la population cible

D.en fonction du nombre de doses de deuxièmes doses et de quatrièmes doses administrées à la population cible

Q375.La gestion de l'information sanitaire consiste à :

A.enregistrer les données sanitaires dans les registres d'activités,

B.stocker l'information sanitaire dans les fiches de rapports

C.transmettre les données aux différents niveaux concernés de la pyramide sanitaire

D. traiter les données pour produire une information utilisable

E.analyser les données

F.interpréter les données

G.utiliser l'information produite.

Q376.Au 15 avril 2018,le taux de promptitude d'un CSR qui a déposé tous ses rapports de janvier, février et mars de l'année 2018,dans les délais requis est de :

A.100%

B.25%

C.15%

Q377.Au 15 avril 2018, le taux de promptitude d'un CSR qui a déposé tous ses rapports de janvier, février et mars dans les délais requis est de :

A.100%

B.25%

Q378.Au 31 décembre 2018, le taux de promptitude d'un CSR qui a transmis 11 fiches de rapports A au district sanitaire dans les délais requis est de :

A.100%

B.91,66%

C.95%

Q379.L'utilisation de l'information sanitaire permet :

A.de mener des réflexions sur l'évolution des activités

B.de mener des réflexions sur l'état de santé de la population

C.d'identifier et d'analyser les causes des écarts entre ce qui est par rapport à ce qui était attendu

D.de planifier les activités dans le cadre de la modification

E.de prendre des mesures immédiates pour améliorer la situation

F.d'assurer la surveillance épidémiologique

Q380.L'information sanitaire est diffusée pour :

A.les décideurs du ministère de la santé et de l'hygiène publique

B.les Administrateurs des projets de santé

C.les gestionnaires des programmes de santé

D.les partenaires au développement

E.les dirigeants des communautés pour des actions communautaires

F.le personnel des organismes intervenant dans le secteur de la santé

G.les organisations non gouvernementales pour leurs activités

Q381.Le nombre de fiche de rapports mensuels que chaque structure de santé doit commander par an est de :

- A.12
- B.24
- C.02
- D.04

Q382.Les niveaux de gestion de l'information sanitaire sont

- A.Le niveau des Etablissements Sanitaires de premier contact (ESPC)
- B.Le niveau des Hôpitaux Généraux ou de référence ;
- C.Le niveau des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) ;
- D.Le niveau des Directions Départementales de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
- E.Le niveau des Directions Régionales de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
- F.Le niveau des Centres Hospitaliers et Universitaires (CHU) où le SIG n'est implanté que partiellement.

Q383.Les différents types d'outils de traitement des données sanitaires sont:

- A.Les supports d'information individuelle
- B.Les registres d'activités;
- C.les fiches de rapport de morbidité quotidienne hebdomadaire ;
- D.les fiches de rapports mensuels et annuels
- E.les ordinateurs
- F.les logiciels
- G.les calculatrices

Q384.Les différents types d'outils de collecte des données sanitaires sont:

- A.Les supports d'information individuelle
- B.Les registres d'activités;
- C.les fiches de rapport de morbidité quotidienne hebdomadaire ;
- D.les fiches de rapports mensuels et annuels
- E.les ordinateurs
- F.les logiciels
- G.les calculatrices

Q385.Les éléments suivants sont des supports d'information individuelle

- A.le carnet de santé
- B.la fiche de référence et de contre référence
- C.la fiche de planification familiale ;
- D.la fiche de traitement de la lèpre
- E.les registres d'activités;
- F.les fiches de rapport de morbidité quotidienne hebdomadaire ;
- G.les fiches de rapports mensuels et annuels

Q386.Le registre est :

- A.un aide-mémoire du praticien ;
- B.une pièce médico-légale
- C.une base de données
- D.un outil d'analyse des données
- E.un outil de collecte des données.

Q387.Selon l'OMS, le nombre de séances de vaccination pour une population de 13000 habitants est de :

- A.03 séances par semaine
- B.02 séances par semaine
- C.12 séances par mois
- D. 03 séances par mois

Q388.L'exécution d'une séance de vaccination se fait selon les étapes suivantes :

- A.l'information des populations cibles
- B.le choix des stratégies vaccinales
- C.la commande des vaccins
- D.l'étape de tri
- E.l'étape de l'enregistrement ;
- F.l'étape de la vaccination proprement dite ou administration de vaccin ;
- G.l'étape de l'IEC /CCC sur les MAPI

Q389.Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui sont des outils de la chaîne du froid :

- A.les vaccins
- B.les solvants
- C.le porte vaccin ;
- D.les accumulateurs de froid congelés ;

E.les PCV

F.le thermomètre

Q390. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui sont des intrants :

A.le personnel soignant

B.le nombre de séances de vaccination organisées

C.le nombre de kit d'IST distribuées

D.le nombre de femmes utilisant les méthodes contraceptives

Q391. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui sont des extrants :

A.le nombre de séances de formation

B.le nombre de femmes sensibilisées

C.le nombre de préservatifs distribués

D.le budget de réalisation du projet

E.les registres de consultations

Q392. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui indiquent un processus

A.le programme des activités

B.le taux de couverture vaccinale

C.le taux d'abandon global de la vaccination

D.la sensibilisation de la population

E.le dénombrement des populations cible

F.la commande des vaccins

Q393. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui indiquent les effets

A.le couverture vaccinale mensuelle

B.le taux de prévalence des maladies cible du PEV

C.le taux d'utilisation mensuelle des contraceptifs

D.le nombre de contraceptifs distribués

E.le nombre de séances de consultations foraines

Q394. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui indiquent l'impact

A.le taux de natalité de la population

B.l'intervalle intergénésiq

C.le nombre de séances de ccc

D.le nombre de personnes sensibilisées

Q395.L'évaluation initiale permet de répondre aux questions suivantes :

- A.Quels sont les besoins des populations que le programme/ projet devra atteindre?
- B.Comment le programme/ projet devrait-il être conçu pour répondre aux besoins des populations ?
- C.Quelle serait la meilleure manière d'exécuter ce programme/projet?
- D.Quels sont les services qui ont été fournis?

Q396.Le suivi des intrants permet de répondre aux questions suivantes :

- A.Quelle est la valeur de l'argent qui a été dépensée ?
- B.Combien de personnes ont-elles été dénombrées ?
- C.Combien d'individus ont-ils travaillé pendant le projet?
- D.Combien de doses de vaccins ont-elles été commandées ?
- E.Combien de doses de vaccins ont-elles été utilisées pendant le projet ?

Q397.Le suivi des extrants permet de répondre aux questions suivantes :

- A.Quels sont les services qui ont été fournis?
- B.Quelle est la population qui a été desservie ?
- C.Combien d'individus ont-ils été servis?
- D.Combien d'individus ont-ils travaillé pendant le projet?
- E.Combien de doses de vaccins ont-elles été commandées ?

Q398.Le suivi des effets permet de répondre aux questions suivantes :

- A.les connaissances escomptées ont-elles été acquises ?
- B.le changement de comportement attendu s'est-il produit ?
- C.l'utilisation des services par les clients s'est elle produite ?
- D.L'intervention prévue a-t-elle été exécutée ?
- E.Combien de doses de vaccins ont-elles été commandées ?

Q399. L'évaluation d'impact vise à répondre aux questions :

- A.Quels sont les effets à long terme des interventions ?
- B.Le changement de comportement est-il imputable au projet ?
- C.Combien d'individus ont-ils travaillé pendant le projet?
- D.Combien de doses de vaccins ont-elles été commandées ?

Q400.Les principales sources de données d'un projet/programme sont :

- A. les registres

- B.les rapports du projet / programme
- C.les rapports d'enquête
- D.Les rapports d'activités
- E.les rapports d'évaluation
- F.les documents administratifs
- G.les documents financiers officiels
- H.les Cartes et graphiques officiels

ETUDE DE CAS

EXERCICE 1

Vous venez d'être affecté au centre de santé rural de Mébo où vous avez pris service le 20 Mai 2017 pour mener des activités de soins de santé primaires. Avant de débiter vos activités de soins, vous procédez par une évaluation initiale des activités menées par votre prédécesseur et une brève monographie qui vous permettent de noter entre autres, les informations suivantes :

- les populations s'approvisionnent en eau de boisson non potable ;
- les ordures ménagères sont dispersées autour des habitats ;
- l'effectif des femmes en âge de reproduction de l'aire sanitaire du centre de santé de ce village est estimé à 1700 au 31 Décembre 2016.
- l'effectif de la population de cette même aire sanitaire projetée au 1^{er} janvier 2018 est estimée à 8755 habitants ;
- les pathologies prédominantes de la localité sont le paludisme, la dysenterie amibienne, les infections respiratoires aiguës, la fièvre typhoïde, la malnutrition ;
- les taux de perte des vaccins BCG, VAR, VAA, VPO, DTC-Hep-Hib sont estimés respectivement à 52%,28%,36%,10% et 2% ;
- 2 tuberculeux adultes, traités à l'aide de la stratégie TDO ;
- 03 cas de rougeole enregistrés pendant le mois de Janvier 2017.

QUESTIONS

- 1-Précisez en justifiant votre réponse à partir du texte, les composantes de soins de santé primaires qui orienteront vos activités en vue d'améliorer la santé de la population de l'aire sanitaire de Mébo.
- 2-Calculez la population totale de l'aire sanitaire de Mébo au 31 décembre 2016.
- 3-Calculez le taux d'accroissement annuel (TAA) de la population de l'aire sanitaire de Mébo.
- 4-Quelle sera l'effectif de la population cible du premier monitoring des activités de vaccination de l'aire sanitaire de Mébo en 2017 ?
- 5- Citez les déterminants de couverture utilisés pour réaliser le monitoring de ces activités de vaccination.
- 6-Parmi les vaccins mentionnés dans le texte, quels sont ceux dont les taux de perte dépassent les normes de perte du P.E.V. ? Quelle raison spécifique liée à ces vaccins permet-elle de justifier l'élévation de leur taux de perte ?

7-Parmi les maladies prédominantes enregistrées chez les habitants de l'aire sanitaire du CSR de Mébo, relevez celles qui ont un lien direct avec la consommation de l'eau non potable.

8-Citez les qualités physiques d'une eau potable.

9-Quels conseils comptez-vous donner à la population pour lutter contre, d'une part les larves de moustiques et d'autre part les moustiques adultes en vue de réduire l'incidence du paludisme en 2017 ?

10-Définissez le sigle TDO et précisez en quoi consiste cette stratégie de traitement de la tuberculose.

11-L'un des enfants rougeoleux enregistrés pendant le mois de janvier 2017 présentait dans son carnet de santé un calendrier de vaccination à jour pour tous les vaccins du P.E.V.

Donnez trois (03) raisons pouvant justifier la survenue de la rougeole chez cet enfant supposé avoir reçu le VAR.

NB : Calculez les différents taux en pourcentage

EXERCICE N°2

Après votre formation d'infirmier(ère) et de Sage-femme, vous êtes affecté(é) au centre de santé urbain de Baya, dans le district sanitaire de Boundiali où vous avez pris service le 16 octobre 2014. Le taux d'accroissement annuel de la population de l'aire sanitaire de ce centre est constant et estimé à 2%. Une brève étude de l'aire sanitaire et l'analyse des rapports d'activités de l'année 2015 ont permis de noter entre autres, les informations suivantes :

- un nombre important d'habitats ne respectent pas les conditions de salubrité recommandées ;
- le comité de gestion du centre de santé n'est pas fonctionnel ;
- 125 naissances vivantes enregistrées ;
- les maladies prédominantes sont la malnutrition, la fièvre typhoïde, les IRA, le paludisme et la dysenterie amibienne ;
- 18 décès d'enfants dont 02 après leur premier anniversaire ;
- 56 décès d'adultes dus majoritairement aux IRA et au paludisme.

La population cible du premier monitoring des activités de vaccination de l'année 2015 effectué par l'Equipe Cadre du District (ECD) était estimée à 170 enfants âgés de 0 à 11 mois. Ce monitoring a permis de noter un important goulot d'étranglement entre la disponibilité des ressources et l'accessibilité géographique aux soins.

QUESTIONS

- 1-Citez les critères consensuels relatifs aux besoins psychologiques permettant d'apprécier la salubrité de l'habitat.
- 2-Parmi les maladies prédominantes enregistrées chez les habitants de l'aire sanitaire du CSU de Baya, relevez celles qui ont un lien direct avec la consommation de l'eau non potable.
- 3-Citez les qualités physiques d'une eau potable.
- 4-Citez quatre sources des revenus et quatre domaines de dépenses du comité de gestion d'un centre de santé.
- 5-Calculez pour l'année 2015 :
 - 5-1-La population totale de l'aire sanitaire du CSU de Baya.
 - 5-2- Le taux de mortalité infantile.
 - 5-3- Le taux brut de mortalité de la population.
- 6-Citez les déterminants de couverture utilisés pour réaliser le monitoring des activités.
- 7-Citez deux causes probables de l'important goulot d'étranglement identifié et proposez deux solutions pour le lever.
- 8-Schématisez le circuit de l'information sanitaire produite au sein du CSU de Baya.
- 9-Quel est le besoin théorique du VAR utilisé pendant les activités de vaccination qui ont fait l'objet du monitoring.
- 10-Citez trois indicateurs pouvant vous permettre d'évaluer l'impact de votre activité de vaccination sur la santé de la population de l'aire sanitaire du CSU de Baya à la fin de l'année 2015.

NB : Calculez les différents taux en pourcentage !

EXERCICE N°3

Après votre formation d'infirmier(ère) et de Sage-femme, vous êtes affecté(é) le 25 novembre 2013 au centre de santé rural de Fotokouamekro, dans le district sanitaire de Bouaké. La population de l'aire sanitaire qui était de 8 500 habitants au 31 /12/ 2013 est passée à 8755 habitants au 1^{er} /01/ 2015. Une brève étude du milieu au niveau de l'aire sanitaire et l'analyse des rapports d'activités de l'année 2014 ont permis de noter les informations suivantes :

- 225 naissances vivantes.
- 45 décès d'enfants dont l'âge est compris entre 0 et 10 mois
- 350 décès d'adultes dont 75 dus aux IRA, 165 au paludisme, 25 à la dysenterie amibienne et 85 à d'autres causes diverses.
- 1220 cas de paludisme contractés par des adultes dont 160 chez les femmes enceintes ;
- 05 enfants de 0 à 11 mois atteints de rougeole ;
- 1 cas suspect de méningite âgé de 25 ans ;
- 75 jours de rupture en comprimé de féfol et 2 mois de rupture en paracétamol ;

Par ailleurs un monitoring et une évaluation réalisés par l'Equipe Cadre du District (ECD) sur l'activité de vaccination au 1^{er} semestre de l'année 2015 chez les enfants de 0 à 11 mois ont permis de faire les constats suivants :

- un important goulot d'étranglement entre la disponibilité des ressources et l'accessibilité géographique aux soins ;
- un taux de couverture vaccinale de 45% en VAR atteint pendant le premier semestre ;
- des taux de perte semestriels de 56%,4%,14%,12%,28%,40% respectivement en BCG, DTC-HEPB-Hib, VPO, VAR et VAA ;
- un nombre important des habitats ne sont pas salubres.

QUESTIONS

- 1- Précisez en justifiant votre réponse à partir du texte, les composantes de soins de santé qui orienteront vos activités en vue d'améliorer la santé de la population de Fotokouamekro
- 2- Quels sont les signes sur lesquels s'est fondée votre suspicion de méningite chez l'adulte de 25 ans que vous avez notifié en 2014 ?
- 3-Citez les critères consensuels relatifs aux besoins physiologiques permettant d'apprécier la salubrité de l'habitat.
- 4-Calculez le taux d'accroissement annuel de la population de l'aire sanitaire du CSR de Fotokouamekro.

5-Calculez pour 2014 :

5-1-Le taux brut de mortalité de la population.

5-2-Le taux brut de mortalité infantile.

5-3-Le taux de létalité du paludisme au sein de la population des adultes.

6-Calculez la population totale attendue en 2015.

7-A partir des résultats du monitoring réalisé dans le centre :

7-1-Relevez deux causes probables de l'important goulot d'étranglement identifié.

7-2-Indiquez deux stratégies susceptibles de lever ce goulot d'étranglement.

7-3-Quelle est l'effectif de la population cible qui a servi à réaliser ce monitoring ?

8-Relevez dans le texte, les vaccins dont les taux de perte sont anormalement élevés et donnez une explication à la perte importante de ces antigènes.

9-Calculez le nombre d'enfants de 0 à 11 mois qui reste à vacciner pour le second semestre de l'année 2015 avec le VAR si l'on veut atteindre l'objectif annuel visé par le PEV ivoirien.

10-Faites une estimation des besoins théorique en VAR pour ces enfants restant à vacciner pendant le second semestre de l'année 2015.

11-Faites le schéma annoté de la pyramide sanitaire de la Côte d'ivoire.

NB : Calculez les différents taux en pourcentage !

EXERCICE N°4

Le centre de santé de Pinvoro compte 15000 habitants au 31/12/2017 avec un taux d'accroissement annuel constant de 2,5%.

Par ailleurs, tous les rapports mensuels de ce centre de santé au titre de l'année 2018 ont été reçus par le responsable CSE dont trois après le délai requis.

Le rapport d'activités annuelles mentionne les informations suivantes :

Données épidémiologies, sanitaires et environnementales pour l'année 2018 :

- Nombre total de cas toutes causes confondues : 2000
- Nombre de décès toutes causes confondues : 20
- Le paludisme sévit dans la région sanitaire de Bouaflé de façon endémique avec 600 cas notifiés dont 2/3 d'anciens cas.
- 10 cas de rougeole chez les enfants de 0 à 5 ans dont 05 décès.
- 1 cas de tuberculose

NB : N=2

QUESTIONS :

- Q95. Un des buts de la stratégie DOTS est de mettre un terme à l'épidémie mondiale de la tuberculose en réduisant le nombre de décès de 85% et l'incidence de 90% entre 2015 et 2035. A. vrai B. faux
- Q96. Un des objectifs de lutte antituberculeuse au niveau central et intermédiaire est d'impliquer la communauté dans les activités de lutte contre la tuberculose. A. vrai B. faux
- Q97. Parmi ces composantes essentielles des soins de santé primaires, une ne sera pas votre priorité. Laquelle ?
A. Education appropriée pour la santé en relation avec les problèmes de santé auxquels la population est confrontée.
B. Traitement des maladies et lésions courantes.
C. Vaccination contre les principales maladies infectieuses.
D. Prévention et la lutte contre les endémies locales.
- Q98. Parmi les éléments suivants, relève la seule méthode de communication pouvant aider cette population à participer à la résolution de ses problèmes de santé :
A. La télévision
B. Les affiches
C. Les réunions
D. Les vidéoprojecteurs.
- Q99. Le taux de promptitude des rapports mensuels de Pinvoro en 2018 est :
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%

Q100. Le taux brut de mortalité de Pinvoro en 2018 est :

- A. 0,11%
- B. 0,12%
- C. 0,13%
- D. 0,15%

Q101. Le taux de morbidité de la rougeole chez les enfants de 0 à 5 ans en 2018 est :

- A. 0,32%
- B. 0,33%
- C. 0,34%
- D. 0,35%

Q102. La population cible à vacciner contre la rougeole en 2019 est :

- A. 631 enfants
- B. 788 enfants
- C. 2730 enfants
- D. 3152 enfants

Q103. Le besoin théorique du vaccin antirougeoleux (TP : 25% ; FP : 1,33% ; OV : 92%) pour le premier trimestre est :

- A. 965 doses
- B. 966 doses
- C. 967 doses
- D. 968 doses

Q104. La quantité de vaccins à commander pour le premier trimestre (stock existant = 0) est :

- A. 1205 doses
- B. 1206 doses
- C. 1207 doses
- D. 1208 doses

EXERCICE 5

Un centre de santé dispose à la banque la somme de 850 450 f non compris les intérêts et les agios qui sont respectivement de 10000 et 5000f. Les recettes de six mois couverts par le monitoring font parties de la somme à la banque. Les recettes issues de la vente des médicaments essentiels se chiffrent à 240.000f . Celles issues du coût des actes de santé représentent la moitié des recettes des médicaments essentiels. Les dépenses obligatoires sont égales à 250.000f.

A partir des données financières de ce centre, déterminez les éléments ci-dessous

Q1. La somme à la banque après mouvement bancaire du centre est égale à

- A.855.450f
- B.845.450f
- C.865.450f
- D.860.450f

Q2. Les recettes issues du coût des actes de santé sont estimées à

- A.120.000f
- B.220.000f
- C.210.000f
- D.112.000f

Q3. La somme à budgétiser du centre est égale à

- A.352000 f
- B.460.000f
- C.360.000f
- D.450.000f

Q4. Le fonds de réserve est égal à

- A.403.450f
- B.290.450f
- C.500.450f
- D.415.450 f

Q5. Les dépenses du fonctionnement local du centre

- A.102.000f
- B.110.000f

C.210.000f

D.200.000f

Q6. Les autres dépenses de fonctionnement local en dehors des montants alloués à l'immeuble et aux imprévus

A.178.000

B. 86.700

C.170.000

D.93.500